

第一講 脈學溯源

“切脈治病”已成為中醫診斷學上唯一的武器，本來相等于這武器的，還有“望”“聞”“問”三種，難經說：“望而知之謂之神，聞而知之謂之聖，問而知之謂之工，切而知之謂之巧”。這就是從古代傳到現在的“四診”。但時下有些中醫，竟不惜廢棄了望、聞、問三種，單講切脈，便洞知疾病，而有所謂“三指禪”了！因此一般病家找中醫看病，便直捷了當地叫做“看脈”，“看脈開方”也就成了中醫處理疾病的具體步驟，也就是盡到了診斷的能事。“上焉者”通過了切脈，還知其人的貧富貴賤，壽夭窮通，就是一般所謂的“太素脈”。這樣“神氣”的脈學，究竟是那個大發明家的發明？創始於什麼時代？真有這樣地“神氣”嗎？這些問題，都值得我們談談。

周禮上說：“以五氣、五聲、五色、視其死生，兩之以九竅之變，參之以九臟之動”。賈疏：“臟之動，謂脈之至與不至，謂九臟在內，其病難知，但診脈至與不至也。”這就是醫經里“四診”的主要根據，也可說是切脈在史冊上的最早見到。史記說太倉公“傳黃帝扁鵲之脈書”，這根本是句空話，實際上“黃帝脈書”和“扁鵲脈書”都是沒有的，不獨此也，我們在史冊上曾見到這樣一些脈書書目：

脈經、脈經略、黃氏脈經、脈生死要說、亡名氏脈經、三部四時五臟辨診色決事脈、華佗現形察色并三部脈經（以上見隋志）。涪翁診脈法（見後漢書郭玉傳）、素女脈訣、夫子脈訣（以上見禮記正義）。黃帝脈經、扁鵲脈經、張仲景脈經（以上見宋志）。黃帝脈訣、倉公生死祕要（以上見崇文總目）。扁鵲脈髓（見叢竹堂書目）。

這些有名無實的脈書，很可能是出於好事者偽造名目，以作他自圓其說的“擋箭牌”。目前可以看到的脈書除“內”“難”有部份談脈而外，就以“王叔和脈經”，算是脈書中老牌子。王叔和專心立志地著了一部脈書，他對脈學的看法是怎樣的呢？脈經自序：“脈理精微，其體難辨，弦緊浮芤，展轉相類，在心易了，指下難明，謂沉為伏，則方治永乖，以緩為遲，則危殆立至，況有數候均見，異病同脈

者乎。”

王叔和这位大师，他对脉学的修养，也不过就是“在心易了，指下难明”，如斯而已。王叔和是传脉学的祖师，他自己虽说是：“撰集岐伯以来，逮于华佗”，但拿它“脉经十篇”的内容来看，是跑不出“难经”范围的。“难经”的作者相传是扁鹊（？），但扁鹊的特长，是临床经验丰富，治疗技术高明，而不在传脉学，老实说，他就不十分讲究切脉。如史记扁鹊传：“乃悉取其禁方书尽与扁鹊，忽然不见，殆非人也。扁鹊以其言饮药，三十日，视见垣一方人，以此视病，尽见五脏癥结，特以诊脉为名耳。”

这明明说扁鹊得到长桑君传授的是“禁方”，是吃了三十日的“上池水”，凭他这点本领，已“尽见五脏癥结，视见垣一方人”切脉已无用武之地。有时切脉，无非是个“名气”罢了（特以诊脉为名耳），就是说切脉并不是主要的。不信，请看他的两个医案：

史记扁鹊传：“当晋昭公时，诸大夫强而公族弱，赵简子为大夫，专国事，简子疾，五日不知人……扁鹊曰：血脉治也，而何怪？昔秦穆公尝如此七日而寤……今主君之病与之同……居二日半，简子寤。”

史记扁鹊传：“太子病，气血不时……暴蹶而死。扁鹊曰：其死何如时？曰：鸡鸣至今日。收乎？曰未也。其死未能半日也。……入诊太子，当闻其耳鸣而鼻张，循其两股以至于阴，当尚温也……所谓尸蹶者也……扁鹊乃使弟子阳厉鍼砥石，以取外三阳五会，有间，太子苏，乃使子豹为五分之熨，以八减之齐和羹之，以更熨两脅下，太子起坐，更适阴阳，但服汤二旬而复故。”

前一个医案，是他经验丰富的成功，后一个医案，就是他临床诊察周详，和针灸技术的高明。所以他干脆的说：“越人之为方也，不待切脉。”他又坦白的说：“越人非能生死人，此自当生者。”余云岫先生骂扁鹊“是江湖医第一滑头货”我是不同意的。他为“带下医”“耳目痹医”“小儿医”，都享盛名，这是他灵活运用经验，临床精详不苟，实际技术高明的结果。不过太史公说：“天下言脉者由扁鹊也。”这应由太史公负责，因扁鹊本人没有承认凭切脉治病，长桑君亦没有传脉学给他，“天下言脉由扁鹊”这句话从何说起。

呢？于是結合着“難經”不是扁鵲著的書的說法，（唐王勃序難經說：“黃帝八十一難，是醫經之秘錄也。昔者岐伯以授黃帝，歷九師以授伊尹，伊尹以授湯，湯歷六師以授太公，太公授文王，文王歷九師以授醫和，醫和歷六師以授秦越人，越人始定章句，歷九師以授華佗，佗歷六師以授黃公，黃公以授曾夫子。”）扁鵲既沒有矜持切脈，也不曾著傳脈學的“難經”，充其極也不過“定章句”而已！反之，太倉公對於脈法，到還相當有興趣，因為他的老師公乘陽慶，曾以脈學教他（傳黃帝扁鵲脈書），他自己亦說：“謁受其脈書上下經”，因此，他的“神乎其技”，完全憑切脈了。如史記太倉公傳：“齊侍御史成，自言病頭痛，臣意診其脈，得肝氣，肝氣濁而靜，此關內之病也。脈法曰：脈長而弦，不得代四時者，其病主在于肝。”

“齊王中子諸嬰兒小子病，召臣意診，切其脈，告曰：氣隔病……所以知小子之病者，診其脈，心氣也……脈法曰：脈來數，病去難而不一者，病主在心。”

“齊郎中令循病，眾醫皆為蹶，人中而刺之。臣意診之，曰湧疝也，令人不得前後洩……所以知循病者，切其脈時，右口氣急，脈無五藏氣，右口脈大而數，數者中，下熱而湧，左為下，右為上，皆無五藏應，故曰湧疝。”

“齊中御府長信病，臣意入診其脈，告曰：熱病氣也……所以知信之病者，切其脈時，并陰。脈法曰：熱病陰陽交者死，切之不交，并陰。并陰者，脈順清而愈。”

以下還有“齊王太后病”等十多案，都是憑脈斷症，并根据“脈法”，道出病理，確定治法和預后，這証明太倉公的脈學是有相當造詣的。以後他教徒弟，亦主要是傳脈學。例如史記太倉公傳：“問臣意曰：吏官嘗有事學意方，及畢竟得意方不？何縣里人？對曰：臨菑人朱邑，臣意教以五診（正義註：謂診五臟之脈），歲余。濟北王遣太醫王禹學，臣意教以經脈高下，及奇絡結……歲余。菑川王遣太倉馬長馮信正芳，臣意教以按法順逆……。高永侯家杜信喜脈，來學，臣意教以上下經脈五診，二歲余。臨菑召里唐安來學，臣意教以五診上下經脈，奇咳四時應陰陽重，未成，除為齊王侍醫。”

他教這麼多徒弟，都是傳脈學，他亦很矜持的說：“意治病入，

必先切其脈，乃治之，敗逆者不可治，其順者乃治之，心不精脈，所期死生，視可治，時時失之。”這是說：把脈切得准，斷病治療就准，有時粗枝大葉，沒有把脈切得準確，斷病治療就沒有把握，這樣太倉公還不夠稱一位脈學大師么。所以我說太史公“天下言脈者由扁鵲”這個說法，是不公道的。中醫單憑切脈診病，應該以太倉公為祖師，有人說：“自晉王叔和作脈經，于是我國醫士診病專憑切診。”這種說法也是不正確的。

王叔和的脈經，確是集“內”“難”之大成，是中醫脈學里的一部具體的專書。所以以後的脈書，都是祖述于他，甚至还偽託他著成“王叔和脈訣”“王叔和小兒脈訣”等欺枉後世，那末，王叔和“脈經”的價值究竟怎樣呢？徐靈胎醫學源流論的批評，比較公道：“內難脈經及仲景之論脈，其立論反若甚疏，而應驗如神，若執脈經之說，以為某病當見某脈，某脈當得某病，雖內經亦間有之，不如是之拘泥繁瑣也。”

王叔和“脈經”和“難經”都說得繁瑣剝雜，“內經”比較要具體而微，“傷寒論”“金匱要略”的脈法，到要着實得多，所以徐靈胎醫學源流論說：“必當先參于內經難經及仲景之說，而貫通之，則胸中先有定見，見後人之論，皆足以廣我之見聞，而識力愈真，此讀脈經之法也。”可是，不管“內”“難”和“王氏脈經”，都是不主張單純切脈斷症的，所以內經素問征四失論說：“診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷于毒，不先言此，卒持寸口，何病能中，妄言作名，為竊無窮。”

“難經”儘管說得龐雜，而六十一難仍以切脈為下乘，不是診斷上的要着。王叔和固然立意傳脈學，他在“脈經”里亦強調的說：“聲色証候，靡不該備”。“金匱”說：“上工望而知之，中工問而知之，下工切而知之。”脈法在漢唐以前也只不过站得這樣一個地位。唐宋以後的脈學，愈是演繹支離而不可聞問，所以王元標大胆地暴露說：“以兩指按人之三部，遂定其某腑某臟之受病，分析七表八里九道，毫毛不爽，此不但世少其人，雖古亦難有也，此不過彼此相欺耳。”寇宗奭亦說：“據脈供藥，是醫家公患。”

于此我可以肯定的說：（一）望、聞、問、切是中醫具體的診斷

方法，不能割裂單用，切脈的作用更不能大过于望、聞、問三診。單憑切脈斷症，這是錯誤的。（二）切脈是古法，可能在周秦時候就有了，具體記載于內經，實驗于張仲景，演繹于王叔和。（三）扁鵲並不矜持脈法，單純的據脈斷症，“作俑”的是始于太倉公。

第二講 脈搏的生理

有的中醫為什麼單獨着重切脈呢？大多由於養成了“取巧”的作風，脈是“視而不見，听而不聞”的（不包括血循環科學的含義），隨便捉捉手，便可以任性地大談出一番道理來麻痹病人，炫耀自己的工夫，反正是沒有根據的，這裡有三種人：下焉者一無所知，用切脈來裝點門面，“一切病情先生已從脈上看出來了”。稍好一點的，讀過幾首“脈訣”，例如：

“寸脈急而頭痛，弦為心上之咎；

緊是肚痛之征，緩即皮頑之候；

微微冷入胸中，數數熱居胃口。

滑主壅多，瀯而氣少；

胸連脅滿，只為洪而莫非；

臍引背疼，緣是沉而不謬。”——脈賦

於是切着“急脈”，便說病人頭痛；切着“弦脈”，便說病人心下有痰飲；切着脈“緩”，便說他皮膚不仁；切着脈“微”，便說他胸中有冷氣似的，好像准此“無往而不利”，便憑着切脈來炫耀本領。“上焉者”如太倉公之流，穿鑿附會，頭頭是道，如史記太倉公傳：“齊王太后病，召臣意入診脈，曰：風痺客脾，難于大小便，溺赤，臣意飲以火齊湯，一飲即前後洩，再飲病已，溺如故，病得之流汗出瀦，瀦者，去衣而汗晞也。所以知齊王太后病者，臣意診其脈，切其太陰之口濕然，風氣也。脈法曰：沉之而大堅，浮之而大緊者，病主在腎，腎切之而相反也，脈大而躁，大者膀胱氣也，躁者，中有熱而溺赤。”

齊王太后由於出汗感冒，患症候性的便秘尿赤，多喝點開水，

便可以解決問題，偏走了“太陰濕”“膀胱氣”“主在腎”“大堅”“大躁”這大一個彎路，仍然說得不明不白，這些都是由於不明白脈搏的生理作用的緣故。

要懂得脈搏的生理，就先要懂得心臟的唧筒作用，這點，內經也是承認的：

素問六節臟象論：“心者，生之本神之變也，其華在面，其充在血脈。”

素問金匱真言論：“南方生赤，入通于心……是以知其病之在脈也。”

素問陰陽應象大論：“在體為脈，在臟為心，在色為赤。”

素問經脈別論：“食氣入胃，濁氣歸心，精淫于脈。”

心是一個唧筒，它保持着血液的循環不息，供給體內所有器官的需要，右心室唧血進肺循環（小循環），左心室唧血進體循環（大循環），假定以左心室收縮的時期開始來講，這時候左心房里充滿了血液，房室瓣是緊閉着，但肺靜脈不斷的把新鮮的血液注入左心房而增加了左心房里血壓，這種壓力終於沖開了二尖瓣，於是血液注入了左心室。左心室開始收縮所產生的壓力，終於沖開了動脈瓣而把血液唧進主動脈。左心室開始舒張了，壓力消失了，但因為主動脈壁的彈性和血液與地心吸力的關係而將半月瓣壓閉，血液向動脈的遠端流去。當左心室把血液逼到主動脈的時候，就產生了一次脈搏，這個脈搏的波，比較血流的速率快得多，每秒鐘可以推進九公尺。這種波愈離心愈弱，到了微血管消失。

如上所述，脈搏向外展開，好像波浪一般，所以又叫做脈搏波，在動脈管系統的任何處，管牆底擴張很快地達到極點，惟在往後的回位則較緩。在毛細管中，因流床驟然變廣，脈搏波便消失了，不能再見，但如果小動脈擴大，有時脈搏也很可能傳至毛細管的，脈書上所載的浮、沉、遲、數各種現象，都從這脈搏波一一反應出來。

循環所需的時間，相當的短，一顆血的微粒，從某一處開始行動，經過肺循環與體循環，仍回到原處，僅需二十三秒鐘。一般的，心跳二十七次，血液即可循環一周。心跳速率的因素很多。一隻象，每分鐘心跳二十次，兔子是一百二十次，老鼠是七百次，總之，

身体愈大，心动速率便愈低。女性平均每分鐘心跳动七十到八十次，男性是六十五次到七十二次。胎兒平均每分鐘心跳一百四十次，嬰兒每分鐘一百十次到一百三十次，兒童是七十二次到九十二次，成人更慢。飯后心动速率要增高，运动时比安静时心动速率也增高，情緒上受到刺激的时候，心动速率也会來一个暫时的增高。影响心动速率的因素有三：（一）化学的。（二）温度的。（三）神經的。于此我們便知道心动的速率，便是脈搏波动的速率，影响心动速率的原因，也就是影响脈搏波动的原因。

这些脈的生理作用，古人是不很正确知道的，即或知道一些，也不透徹。例如灵樞脈度第十七：“气之不得无行也，如水之流，如日月之行不休，故陰脈荣其臟，陽脈荣其腑，如环之无端，莫知其紀，終而复始。其流溢之气，內溉臟腑，外濡腠理。”

以意測之，“內溉臟腑”是肺循环，“外濡腠理”是体循环，这样的“如环无端，終而复始”理論，是比較正确的。如灵樞五十营第十五：“人气行一周，千八分。日行二十八宿，人經脈上下左右前后二十八脈，周身十六丈二尺，以应二十八宿，漏水下百刻，以分晝夜。故人一呼，脈再动，气行三寸；一吸脈亦再动，气行三寸，呼吸定息，气行六寸，十息气行六尺，日行二分，二百七十息，气行十六丈二尺，气行交通于中，一周于身，水下二刻，日行二十五分，五百四十息，气行再周于身，水下四刻，日行四十分，二千七百息，气行十周于身，水下二十刻，日行五宿二十分，一万三千五百息，气行五十营于身，水下百刻，日行二十八宿，漏水皆尽，脈終矣。”

素問平人氣象論：“黃帝問曰：平人何如，岐伯对曰：人一呼脈再动，一吸脈亦再动，呼吸定息，脈五动，閏以太息，命曰平人，平人者，不病也。常以不病調病人，医不病，故为病人平息以調之为法。人一呼脈一动，一吸脈一动，曰少气。人一呼脈三动，一吸脈三动而躁，尺热曰病温，尺不热脈滑曰病風，脈濇曰痹。人一呼脈四动以上曰死，脈絕不至曰死。……胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出于左乳下，其动应衣，脈宗气也。”

“左乳下”正是心尖的部位，“其动应衣”，正是心臟唧血的跳动，以左乳下的动为脈搏动的原动力，而称为“脈宗气”，这是对的，

但牽涉到胃大絡，那又不对了。“宗氣”亦只可以当原動力講，是說得去的；如果以为“人氣行一周”那样說法，就不对。因为心臟的唧血搏動作用，主要是由于心肌的特性，并不是另外有什么“氣”在推動它。有人說：古書上的“氣”字，許多地方都代表了神經作用。但用在这里，仍然說不過去，因为心肌的特性，如它的節律收縮力很強，是先天帶來的，和神經的關係不太大，事實上在胚胎時期，神經尚未形成之前，心已能收縮了。至几寸几丈云云，不但不正确，現在已根本用不着，切脈時只須用附有秒針的時表，計其二十秒的至數而三倍之，或三十秒之至數而二倍之，充其量，計足一分鐘，便得之矣。

脈的搏動率，既是心臟縮張的搏動率，也就是說：脈至數就是心臟縮張的至數，于是便知道脈搏搏動的变化，首先是代表心臟疾病的变化，或是全身疾病的变化，切脈就是考察心臟与全身病变方法的一种，无所祕密，无所神氣，不过要注意的一点，動脈管本身起了病变，也是常常影响脈搏的，不容漠視。有的中医过于偏信脈法，不惜穿鑿附會，也就是沒有徹底了解脈的生理的原故。

第三講 三部脈法与橈骨動脈

只要是動脈淺在的地方，都可以數到脈搏，除我們一般使用的腕部的橈骨動脈外，在耳前也可摸到頸外動脈的顳上枝；胸鎖乳突肌的前緣，摸到頸總動脈，腹股溝中點，摸到股動脈，臍窩里摸到臍動脈；以及腳上的脛前動脈等不一而足。在古時只要審到脈管顯露，或者“脈動应手”，甚至看到“其動應衣”的地方，都進行“切脈”。內經素問三部九候論：“帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天，有地，有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈，上部地，兩頰之動脈，上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；（王冰註：在掌后寸口中，是謂經渠，動应于手。）中部地，手陽明也；（王冰註：在手大指次指歧骨間，合谷之分，動应于手也。）中部人，手少陰也；（王冰註：在掌后銳

骨之端，神門之分，动应于手也。）下部天，足厥陰也；（王冰註：在毛际外，羊矢下一寸半陷中，五里之分，臥而取之，动应于手也，女子取太冲，在足大指本節后二寸陷中是。）下部地，足少陰也；（王冰註：在足內踝，后跟骨上陷中，太谿之分，动应手。）下部人，足太陰也；（王冰註：在魚腹上趨筋間，直五里下箕門之分，寬吮足，單衣沉取乃得之，而动应于手也，候胃气者，当取足跗之上，冲陽之分，穴中脈动乃应手也。）”

以上動脈，除兩額，兩頰，耳前的都很明顯外，手太陰以下的，分列于下：

- 經渠：橈骨動脈。（手太陰）
- 合谷：橈骨動脈。（手陽明）
- 神門：掌側動脈。（手少陰）
- 五里：外陰部動脈。（足厥陰）
- 太冲：跖骨動脈。（足厥陰）
- 太谿：后脛骨動脈。（足少陰）
- 箕門：膝關節動脈。（足太陰）
- 冲陽：循背骨間動脈。（候胃气）

这里知道古人切脈，是要切遍头、手、足的，只有这些地方的動脈比較顯露，容易診察。虽然穿着什么天、地、人的“外衣”，其取义不过就在这一点，也就是“三部九候”的精义。但是，診一个病要切这多处動脈的脈搏，是極不方便的，久而久之，許多医生就在方便的地方，随便巧切兩处，不方便的地方，干脆就不切了。兼以“內經”上一再強調“人迎、寸口、少陰”三部脈的重要，于是更給了当时一般医生作借口，为了節省切脈起見，便舍去九候，只診三部。內經靈樞經脈第十：“肺手太陰之脈……盛則瀉之……不盛不虛，以經取之，盛者，寸口大三倍于人迎；虛者，則寸口反小于人迎也。大腸手陽明之脈……盛則瀉之，虛則補之，熱則疾之，寒則留之，陷下則灸之，不盛不虛，以經取之，盛者，人迎大三倍于寸口，虛者，人迎反小于寸口也。胃足陽明之脈……盛則瀉之，虛則補之……不盛不虛，以經取之，盛者，人迎大三倍于寸口，虛者，人迎反小于寸口也。脾足太陰之脈……盛者，寸口大三倍于人迎，虛者，寸口反小

于人迎也。心手少陰之脈……盛者寸口大再倍于人迎，虛者，寸口反小于人迎也。小腸手太陽之脈……盛者，人迎大再倍于寸口，虛者，人迎反小于寸口也。膀胱足太陽之脈……盛者，人迎大再倍于寸口，虛者，人迎反小于寸口也。腎足少陰之脈……盛者，寸口大再倍于人迎，虛者，寸口反小于人迎也。心主手厥陰心包絡之脈……盛者寸口大一倍于人迎，虛者，寸口反小于人迎也。三焦手少陽之脈……盛者，人迎大一倍于寸口，虛者，人迎反小于寸口也。胆足少陽之脈……盛者，人迎大一倍于寸口，虛者，人迎反小于寸口也。肝足厥陰之脈……盛者，寸口大一倍于人迎，虛者，寸口反小于人迎也。”“……其虛實也，以氣口知之……”。

靈樞動輸第六十二：“黃帝曰：經脈十二，而手太陰、足少陰、陽明獨動不休，何也？岐伯曰：足陽明胃脈也，胃者，五藏六府之海也，其清氣上注于肺，肺氣從太陰而行之……氣之過于寸口也，上十焉息，下八焉伏……足之陽明何因而動？……其悍氣上沖頭者……合陽明，并下人迎，此胃別走于陽明者也。……足少陰何因而動？岐伯曰：沖脈者，十二經之海也，與少陰之大絡，走于腎……并少陰之經……出屬跗上，入大指之間，注諸絡，以溫足脛，此脈之常動者也。”

十二經的盛衰，都可以在“人迎”“寸口”這兩處的脈搏看出來，而常動的脈，又只有“寸口”“人迎”“少陰”（太谿）或“跗陽”这三處，于是當時醫生便有充分理由，省略其他地方，只切按这三處了。“人迎”在頸結喉兩旁，即頸部的左右總動脈，“太谿”和“跗陽”，一個是後脛骨動脈，一個是脛前動脈，“寸口”即橈骨動脈，這幾處脈管都極顯露，正靈樞所謂“脈之見者”，是切脈最便利的地方，這個省略的“三部切脈”法，到了後漢時，有些醫生還嫌麻煩，還以為不方便，還在不斷的再向省略的前途發展，張仲景傷寒論序說：“觀今之醫，不念思求經旨，以演其所知，各承家技，始終順旧，省疾問病，務在口給，相對斯須，便處湯藥，按寸不及尺，握手不及足，人迎趺陽，三部不參，動數發息，不滿五十，短期未知決診，九候曾無髣髴，明堂闕庭，盡不見察，所謂管窺而已。”

在這些時，連“人迎”“寸口”“趺陽”經過省略的这三處動脈，一

般都不耐煩按切了，可見这时的切脈，还在向簡便的方向繼續發展，發展的結果，便是現在的單診寸口脈，即橈骨動脈，廖平對此，頗有充分的意見。他的人寸診補正說：“內經鍼法，于足厥陰肝經云：男子取五里，女子取足太冲，考男女穴法皆同，无別取之必要，經之所以男女異穴而取者，以期門穴必臥而取之，其穴又近毛際，故避而取于足之大趾，久之，妇女足趾亦不可取，俗醫乃沿古經異穴之法，取之于手，行之便利，又推于男子，至喉頸之人迎亦縮于兩寸，人迎虽不如太冲期門之窒碍，以手捫妇女喉頸，亦屬不便，數百年，天下便之，而后難經盛行，故欲行古法，必須女醫。”

又脈學輯要評云：“脈法縮三部于兩寸，于女子纏足大有关系，讀小學載一旗婦，不肯醫持手診脈，宁病而死。仲景叔和，妇女皆診喉足，齊梁俗醫，乃改古法，妇女自難診喉，足弓鞋窄側，其風漸甚，診足之法不能行，醫者从俗，妇女但診兩手，一時利其巧便，因推其法于男子，久之，而難經、脈訣出焉；推其原理，当由纏足階之厉也。”

封建社会和旧礼教的关系，把診三部脈蛻變而为單診寸口，是否純全由于这样，姑不置論，惟“難經”“脈經”問世以后，獨診寸口之風盛行，这却是顯然可見的，仲景書中虽亦間或談到“关”“尺”，那都是后人加入的，說不定就是伪造“難經”之流干的，早已有人評論过。廖平三部篇補正說：“动輸篇三部，寸口，人迎，少陰，为仲景所祖，仲景書中的三部，三处，皆据此而然……間有关尺字，皆为后人所羈，如平脈言三处，后人于其上加入寸口，关中，尺上六字是也。”

余云岫医学革命論也說：“張仲景的伤寒論，他常常說寸口趺陽，趺陽在什么地方，學者意見，頗有不同，这是另一个問題，但是可以証明仲景不是只診寸口動脈的，而且伤寒論自序里面，也很說坐持寸口的醜話，更可以見得仲景是反对只診寸口動脈的人，后来楊上善等，对于寸口脈法，也表示不滿足，可見得寸口診脈的法兒，在漢魏六朝的時候，不是正法，一般學者都看不起，但是他的起源，却是在于難經。”

難經第一難便說：“十二經中皆有動脈，獨取寸口以決五藏六

府死生吉凶之法，何謂也？然；二寸口者，脈之大会，手太陰之動脈也。”这个理由，是多么牽強呀，假如“脈之大会”可以成为理由，診“冲脈”当比診寸口还重要。內經靈樞海論第三十三說：“冲脈者，为十二經之海，其輸上出于大杼，下出于巨虛之上下廉。”靈樞逆順肥瘦第三十八：“夫冲脈者，五藏六府之海也，五藏六府皆稟焉。”素問痿病論：“冲脈者，經脈之海也，主滲灌谿谷。”

为什么不診“冲脈”呢？陸淵雷的診斷治療說得很对：“寸口較之人迎趺陽，尤为便利合用而已，并无他种深妙理由。”

的确，橈骨（寸口）動脈，淺在皮下，最容易触知，診斷時不僅使病人省却麻煩，即用器械檢查，亦最適當，“大会”不“大会”虽說言之有理，却是持之无据，沒有根据的理論，是不足以說服人的。

橈骨動脈沿前臂外側向下，到橈骨莖突上方，本枝轉为橈骨外側，再向下經過第一掌間隙而到手的掌面構成手深弓，最后和尺動脈的掌深枝吻合，这是橈骨動脈一般的解剖情况，但有时越骨而走于外上方，中医称为“反关脈”，因为正当橈骨突起处，旧說叫做“关”的原故，这种“反关脈”不能在平常部位触知，把病人掌側放起，要在手指后面的腕部側，才能切得脈搏，这是解剖上的異常現象。还有一种是尺骨動脈比橈骨動脈要粗大得多，以致寸口的脈搏異常微小，必須靠小指的一边去切按尺骨動脈，这是生理上的異常現象，这两种異常現象，不管在兩手或一只手，都是可以遇着的。

切脈省略到“寸口”以后，同时又來一个变象的“三部九候”的發展，作俑的也是“難經”。十八難說：“脈有三部九候，各向所主之？然：三部者，寸关尺也，九候者，浮、中、沉也。上部法天，主胸以上至头之有疾也；中部法人，主膈以下至臍之有疾也；下部法地，主臍以下至足之有疾也。”这样一变，儼然远古时“人迎，寸口，少陰”各部天地人之法均备，这时一般医生更乐得应用，進而祖述不休。寸、关、尺之分法，“難經”三難說：“从关至尺，是尺內陰之所治也，从关至魚际，是寸口內陽之所治也，故分寸为尺，分尺为寸，故陰得尺內一寸，陽得寸內九分，尺寸終始一寸九分，故曰尺寸也。”至于“关”的定位法，千金方平脈大法第一才有明确的記載：

“問曰：何謂三部脈？答曰：寸關尺也。凡人脩短不同，其形各異，有尺寸分三關之法，从肘腕中橫文，至掌魚际后文，却而十分之，而入取九分，是謂尺；从魚际后文却还度取十分之一，則是寸；寸分之而入取九分之中，則寸口也，此处其骨自高故云。陰得尺內有寸，陽得寸內九分，从寸口入却行六分为關分，从關分又入六分为尺分。又曰：从魚际至高骨却行一寸，其中名曰寸口，从寸口至尺，名曰尺澤，故曰尺寸，寸后尺前，名曰關，陽出陰入，以關為界。”

高骨（橈骨的突起處）為關，關前為寸，關后為尺，从此便成了定案，寸口的三部切脈法，朱肱活人書說得很清楚：“先以中指揣按得關位，乃齊下前后二指為三部脈，……先診寸口，浮按消息之，次中按消息之，次重按消息之，次上竟消息之，次下竟消息之，次推指外消息之，次推指內消息之。”

这个診橈骨動脈的切脈法，傳到現在，依然一成不變，百家恭奉，尤其是宋朝大儒朱熹跋長陽醫書還推崇備至，他說：“予嘗謂古人之于脈，其察之固非一道，然今世通行惟寸關尺之法為最要，且其說具于難經之首篇。則非下俚俗說也。故郭公（郭雍）此書備載其語，而并取丁德用密排三指之法以釋之，夫難經則至矣。至于德用之法，則余竊意診者之指有肥脊，病者之臂有長短，以是相求，或未得定論也。蓋嘗細考經之所以分寸尺者，皆自關而前却（猶言前后）以距乎魚际尺澤。是則所謂關者，必有一定之處，亦若魚际尺澤之可外見而先識也。然今諸書皆无的然之論，惟千金以為寸口之處，其骨自高，而寸關尺皆由是而却取焉，則其言之先后，位之進退，若與經文不合，獨俗所傳脈訣五七言韻語者，詞最鄙淺，非叔和本書明甚，乃能直指高骨而為關，而分其前后以為寸尺陰陽之位，以得難經本旨。”

章太炎對中國醫學本有很多識見，獨于診脈則模糊其詞，这也是由于不識得脈搏生理的原故，章氏論診脈有詳略之法說：“寸口三部，其血管則一耳，寸之浮，關之平，尺之沉，以肌肉厚薄使然。因以浮者候心肺，平者候肝脾，沉者候兩腎及腹，其取義若是矣。及其病也，迟、數、沉、大、小之度，詭于恆時，而三部亦有錯異，或乃一臟病劇，則一部獨應，此固非古人虛說，今世醫師，人人皆得驗而

得之(？)实征既然，不能問其原也，脈本屬心，而他藏府之病，亦可形之于脈，实征既然，亦不能問其原也。”

章氏既知道橈骨動脈只得一條，“脈本屬心”，偏又說它能夠“一臟獨應”，“他藏府之病亦可形之于脈”，理由是：“实征既然，不能問其原”，試問理論（原）都沒有，那里有实践（实征）來，得不出理論（不能問原）的实践，还能算是正确的“实征”嗎？所謂“实征既然”，純出于主觀的見解，章氏这样的治学态度，是不能滿人意的。关于这一点，廖平的見解，要比章氏正确得多，廖平人寸診补正說：“特各經之病，必專診本經之脈，乃为切直，使兩寸可代九藏，則三部九候，經又何必立此繁重之法以困后人哉；必知兩手只为手太陰肺經之脈，脈只一條，非有三截，又非三條可分藏府，仲景本經專診本經之脈，最为捷便，十一經有病，必輾轉假借于寸口，毫釐之差，千里以謬，細考李所說，本因妇女而杜撰診法，以求通俗，此为齐梁以后，私家求售之市道，其不足以言医，固不待煩言而解矣。”

橈骨動脈只此一條，非有三截，只能切得一種脈象，万不能把十一經的病，輾轉假借于寸口，这是可以“問原”的“实征”，廖氏之說是正确的。

第四講 橈骨動脈分主臟腑的不合理

動脈是从心臟運血出去，富于彈性，可以伸縮，質頗強韌的管子，在解剖學上可以分为三層：內層是血管內膜，是彈力纖維組織；中層是肌層，是由平滑肌加雜彈力纖維構成的，外層是血管外膜由彈力纖維構成的。主持動脈血管作用的，是由傳入神經和傳出神經的指使，如迷走神經把靠近心臟大血管的感覺送到中央系統，這是傳入神經；至于血管收縮神經，能收縮血管的肌層，以適應周圍的抗力，收縮中樞在延髓里，假使這個中樞受到了抑制或是機能不足，血管就會比平時還要擴大，但若是中樞機能過份亢進，血管也就異于尋常的縮小。其次是血管舒張神經，當它的作用發揮到血管的時候，血管的直徑就擴大到極度。這兩種是屬於傳出神

經。無論傳入和傳出神經，統屬於血管運動中樞，因此，這個中樞就包括了使血管收縮和舒張的兩個條件，也受着血液成份及從許多傳入路綫沖動的影響，動脈管的解剖生理情況明白了，便可以解得動脈搏動除受心臟影響而外的一些原因。

根據上述動脈血管的解剖生理情況，它的動作是直接受着心臟唧血以及血管運動中樞的指使，沒有其他的臟器可以影響它。至于橈骨動脈的來源，它僅是肱動脈分枝之一（另一枝是尺動脈），肱動脈是腋動脈的續行段，推源而往，仍是由心臟出來的，也沒有任何臟器是它的起根發源地，這些交代清楚了，看看它有分主臟腑的可能嗎？

寸口分主臟腑，實濫觴于“難經”，創立于王叔和，如十八難說：“上部主胸以上至頭之疾，中部主膈以下至臍之疾，下部主臍以下至足之疾。”這無異乎說：頭部和胸腔里臟器的病脈見于“寸”，胸腔到肚臍這一段臟器的病脈見于“關”，肚臍以下臟器和兩足的病脈見于“尺”，理由是“上以候上，中以候中，下以候下”。同時第四難說：“呼出心與肺，吸入腎與肝，呼吸之間脾。”這是呼吸也瓜分了臟腑。四難又說：“浮而大散者，心也；浮而短濇者，肺也；牢而長者，肝也；按之濡，舉指來實者，腎也；脾者，中州，故其脈在中。”切脈的浮中沉也瓜分了臟腑。第九難說：“數者，府也；遲者，臟也。”這是脈搏的快慢也主宰臟腑。不過這還是籠統的分法，還沒有分配給左右手，及王叔和著“脈經”，分主臟腑的立論，便具體些了。例如“脈經”兩手六脈所主五臟六腑陰陽順逆第七：“肝心出左，脾肺出右；腎與命門，俱出尺部。”（原書謂出“脈法讚”）

自此以後，兩手六脈都各有其所主的臟腑了，可惜他們的意見，並不一致，茲把主要幾家的說法，列表如后。

右述四家對臟腑分主的意見，可說沒有那一部是有統一認識的，言人人殊，難坏了陳修園在其間“折沖樽俎”方方應付，都有道理，他在公余六種中很圓滑的說：“王叔和以大小二腸配于兩寸，取心肺與二腸相表里之義也。李瀕湖以小腸配于左尺，大腸配于右尺，上下分屬之義也。張景岳以大腸宜配于左尺，取金水相從之義。小腸宜配于右尺，取火歸火位之義，俱皆近理，當以病症相

			王叔和	張景岳	李時珍	醫宗金鑑
左手	寸	外	心	心	心	膻中
		內	小腸	膻中	膻中	心
	关	外	肝	肝	肝	胆
		內	胆	胆	胆	肝
	尺	外	腎	腎	腎	小腸膀胱
		內	膀胱	膀胱大腸	小腸	腎
右手	寸	外	肺	肺	肺	胸中
		內	大腸	胸中	胸中	肺
	关	外	脾	脾	胃	胃
		內	胃	胃	脾	脾
	尺	外	命門	腎	腎	大腸
		內	三焦	小腸	大腸	腎

參……一家之說，俱不可泥如此。況右腎屬火，即云命門，亦何不可。三焦鼎峙兩腎之間，以應地運之右轉，即借診于右尺，亦何不可乎。”

这样左右說都有理由，反而使臟腑莫知所从了。好在“臟腑不語，又何傷。”這些在寸口主張支配臟腑的，从明朝以后，都抬出內經的老牌子來，大談根據，陳修園也是其中的一個，他們以為內經素問脈要精微論曾說：“尺內兩傍，則季脅也，尺外以候腎，尺里以候腹中，附上左外以候肝，內以候鬲，右外以候胃，內以候脾，上附上，右外以候肺，內以候胸中，左外以候心，內以候膻中，前以候前，后以候后，上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。”

但是，內經上的“尺”字，多不是指的脈，而是指皮膚言，例如素問平人氣象論：“尺熱曰病溫，尺不熱，脈滑，曰病風……尺瀉脈滑，謂之多汗，尺寒脈細，謂之后泄。”

这就是說：皮膚热的叫病溫，皮膚不热而脈滑的叫病風，皮膚濇而脈滑的，多汗，皮膚冷而脈細的，后泄。又如靈樞論疾診尺第七十四：“尺膚滑，其淖澤者，風也；尺肉弱者，解體安臥……尺膚滑而澤脂者，風也；尺膚濇者，風痹也；尺膚粗如枯魚之鱗者，水洩飲也；尺膚热甚，脈甚躁者，病溫也；尺膚寒其脈小者，泄、少氣；尺膚炬然，先热后寒者，寒熱也；尺膚先寒，久之而大热者，亦寒熱也。”

靈樞邪氣臟腑病形第四：“夫色脈與尺之相應也。如桴鼓影響之相應也，不得相失也，……脈急者，尺之皮膚亦急，脈緩者，尺之皮膚亦緩，脈小者，尺之皮膚亦減之而少氣，脈大者，尺之皮膚亦賁而起，脈滑者，尺之皮膚亦滑，脈濇者，尺之皮膚亦濇，凡此變者，有微有甚。”

這些和素問的尺內尺外之說，都是古人診皮膚之法，所以廖平說：“論疾診尺之尺字，為皮字之剝文”。不過，這裡要知道的，古人凡“尺內尺外”和“尺之皮膚”等語，都是指尺澤而言，尺澤在橈骨與上膊的關節部，當二頭肌肌腱的外緣，橈骨肌起始部的內緣，循返迴橈骨動脈分布橈骨神經，外膊皮神經等。尺熱尺濇等語，是泛指一般皮膚。

以上說明以寸關尺分主臟腑，內經是毫不負責任的，而且在內經里還絲毫找不出“關脈”的綫索來呢！

然則，寸口分主臟腑完全沒有根據嗎？有的，根據于“五行大義”引用的“河圖說”：“肝心出左，脾肺出右；腎與命門，并出尺部。”而王叔和“脈經”所引用的“脈法讚”說：“肝心出左，脾肺出右；腎與命門，俱出尺部。”只是一個“俱”字和“并”字之差，可見王叔和根據“脈法讚”，“脈法讚”根據“五行大義”所引的“河圖說”，“五行大義”是講災異的緯書，也就是不可捉摸的玄學，一般主張寸口分主臟腑的，以為這個娘家的出身成份不正派，便想抓出內經來作護符。任作怎樣的掩護，而“左手心肝腎，右手肺脾命”這種生吞活剝的分主辦法，總是离不开“五行生剋”那一套，否則是沒有第二條路可走的，難經十八難：“脈有三部，部有四經，手有太陰陽明，足有太陽少陰，為上下部，何謂也？然：手太陰陽明金也，足少陰太

陽水也，金生水，水流下行而不能上，故在下部也，足厥陰少陽木也，生手太陽少陰火，火炎上行而不能下，故為上部，手心主少陽火，生足太陰陽明土，土主中宮，故在中部也，此皆五行子母更相生養者也。”

儲泳祛疑說引尊生經：“左手之寸極上，右手之寸極下，男子陽順，自下生上，故極下之地，右手之尺，為受命之根本，如天地未分，元氣混沌也，既受命矣，萬物從土而出，惟脾為先，故右手尺上之關為脾，脾土生金，故關上之寸為肺，肺金生水，故右手之寸，越左手之尺為腎，腎水生木，故左手尺上之關為肝，肝木生火，故關上之寸為心。”

說來說去，強以一條動脈分主臟腑的理論，上不宗內經，下難符科學，憑空臆說，仍不離五行往復，無論于古于今，稍為明理者，都不足置辨，即以古還古，請看几輩古人的批評罷！李時珍瀕湖脈學：“余每見時醫于兩手六部之中，按之又按，曰某臟腑如此，某臟腑如彼，儼若臟腑居于兩手之間，可捫而得，種種欺人之丑態，實則自欺之甚也。”

吳草廬文集：“醫者于寸關尺輒名之曰……此心脈，此肺脈，此肝脈，此脾脈，此腎脈者，非也，五臟六腑凡十二經，兩手寸關尺者，手太陰肺經之一脈也……肺為氣所出之門戶，故名曰氣口，而為脈之大会，以佔一身焉！”

王正宗難經疏義：“診脈之法，當從心肺俱浮，肝腎俱沉，脾在中州之說，王叔和獨守寸關尺分部位，以測五臟六腑之脈者，非也。”李、吳、王的說法，固然不尽如人意，然而他們都不信任寸關尺分主臟腑之說，這一點是正確的。

第五講 不合理的機械脈法論

脈搏同心臟的關係，脈搏和心臟的生理，我們都有了比較明確的認識，于是心臟的強和弱，心動的規則與否，有沒有歇止，以及脈管壁有無硬變，血壓的高和低，這些現象是可以從脈搏上直接覺察

得出來的。尤其是关于热性病的診斷和豫后，关系尤大。所以在已經有了檢溫器、血压計、脈波計等物理診斷器械的今日，切脈仍然未可忽視，如伤寒，肺炎之类，它的体温升高，固然是由于病性使然，无足介意，而脈搏的狀態如何，确可为吉凶的預兆。例如伤寒初期超过每分鐘百三十至的，即可知其为重証，宜加以警惕。脈数动摇而忽速忽迟的，也要留意。脈数階梯形漸增，呼吸随之上昇时，这是心臟衰弱的預告，不僅此也，就是脈之大小，脈之張力，脈之息止等，都有关系。真性肺炎，脈搏在百三十至以上者，豫后亦多不良。診察脈搏的主要作用，在这些方面，是很顯著的。如要間接揣知疾病的具体趨勢，自古以來，都要四診合參，不可單憑切脈，所以內經上素問陰陽應象大論說：“善診者：察色按脈，先引陰陽，審清濁而知部份，視喘息，听声音而所苦，觀權衡規矩而知病所苦，按尺寸，觀浮沉滑澀而知病所生，以治則无过，以診則不失矣。”

現在有部份中医，不論診察什么病，把脈不到兩分鐘，便信口說頭痛、腰痛、口干、發熱等，像真有“洞見垣一方人”的神气，誠如張仲景所謂“相對斯須，便處方藥”，連“省疾問病，务在口給”这点工夫都省却了，甚至有的病人要多說兩句話，反說他嚕囂。他們的本領，为什么有这样的“高強”呢？无他，就是記熟几篇机械式脈訣，如斯而已！他們机械到怎么样的程度呢？从診斷治療、以至豫后，无所不包，“脈經”以后，像这类的著作，真已“各尽其長”，茲举几个典型的表列出來，就可以窺其全貌。李中梓的診家正眼机械主病式如下：（表一）

据“脈經”上載，由切脈診斷为某病后，并由此确定应用何藥何方，以为治療，这在“評三关脈”“治宜”等章，都有詳細的記載，列表如下：（表二）

“脈經”里憑着切脈，便可断定人的生死，其一部份，固不无經驗，亦有相当的理由，但便以一概而論，認為定案，未免过于武断，“中藏經”里論診雜病必死脈，便举了五十九种之多，茲就“脈經”診百病生死等章所載数例，表列于下：（表三）

“医宗必讀”还有所謂“內因”“外因”和“不內外因”脈：如喜虛、憂澀、怒濡、恐沉、驚動、悲緊、內因脈也；寒緊、暑虛、燥澀、濕

(表一)

脈 名	原 因	主 病					
		寸		关		尺	
		左	右	左	右	左	右
浮	病在表	伤風、头痛、鼻塞		中焦風	風疾在腸	下焦風火 小便不通	
沉	病在里	短气、胃痛引脅		中寒、痛結、滿悶		背痛、濕癢、淋濁	
迟	病为寒	上寒、心痛、停凝		中寒凝滯 攣筋		火衰小便不禁	
数	病为热	喘欬、口瘡、肺癰		胃热、邪火上攻		相火遺濁 淋瘕	
滑	痰液	咳嗽、胸滿、气逆		胃热、壅气伤食		淋、痢、男 溺血、女 經郁	
澀	血少、精伤	心痛、怔忡		陰虛中熱		淋、血痢	
虛	血虛、伤暑	驚悸、怔忡	自汗气怯	血不营筋	不消化	腰膝痠痹	寒証
实	火热壅結	舌强气涌	嘔逆咽痛	脅痛	气痛	便秘腹痛	相火亢逆
長	气逆火盛	君火为病	滿逆	木实	脹悶	奔豚	相火盛
短	气虛	心神不足	头痛	伤肝	膈病	少腹痛	真火衰
洪	盛滿气壅	心煩舌破	胸滿气逆	肝气太过	脹熱	水枯便难	龍火盛
微	气血大衰	驚怯	气促	痿痺	胃冷	精枯	陽衰
細	諸虛勞損	怔忡不寐	嘔吐气怯	肝竭	脹滿	泄痢遺精	下元冷
濡	髓竭精伤	健忘驚悸	痿虛自汗	血不营筋	脾虛	精血枯	火真元

(續上表)

弱	真氣弱竭	驚悸健忘	自汗短氣	羣急	水谷病	陽虛	陽陷
緊	寒邪諸痛	心滿急痛	喘嗽	傷寒	傷食	臍下痛	奔豚，疝
緩	胃脈、不主病						
弦	痛瘧、痰飲	心痛	胸頭痛	瘧、癰癧	胃寒膈痛	下焦飲	足攣疝痛
動	痛、驚	驚悸	自汗	驚悸拘攣	心脾痛	亡精	龍火盛
促	火亢、物停	心火	肺鳴	血滯	食滯	遺精	灼熱
結	陰寒凝結	疼痛	氣寒	疝瘕	痰滯食停	痿躄	陰寒
代	臟衰危候	兩動一止 三四日死		四動一止 六七日死			
革	表寒、中虛	虛痛	氣壅	疝瘕	虛痛	精空	死
牢	堅積、病在內	伏梁	息賁	血積	陰寒痞癖	奔豚	疝瘕
散	危脈	怔忡	自汗	脹滿	溢飲	水竭	死
芤	失血	心喪血	肺陰亡	肝失血	脾不攝血	便血	精漏
伏	久病	血郁	氣郁	肝血在腹	寒凝水谷	疝瘕	少火消亡
疾	危象						

濡、風浮、熱洪、外因脈也；勞神虛澀，勞力緊，房帷過度微濇，飢緩弦，飽滑實，不內外因脈也。切脈不獨診病，持旧脈法的機械論者，施于妊娠診斷上，亦極有把握(?)“脈經”說：“妊娠初時，寸微小，呼吸五至，三月而尺數也；脈滑疾重，以手按之散者，胎已三月也；脈重手按之不散，但疾不滑者五月也。”不僅診斷妊娠，男女胎兒亦

(表二)

脈部 脈狀	症 狀			治 法		
	寸	关	尺	寸	关	尺
浮	中風發熱頭痛	腹滿不欲食	下熱、風、小便難	桂枝葛根湯	平胃丸	瞿麥湯
緊	頭痛骨肉痛	苦滿急痛	臍下痛	麻黃湯	茱萸當歸湯	當歸湯
微	苦寒為衄	心下拘急	厥逆小腹中拘急	五味子湯	附子湯	小建中湯
數	熱在胃	胃有客熱	惡寒臍下熱痛	吐法	知母丸	鷄子湯
緩	皮膚不仁風寒在肌肉	不欲食	小便赤黃、脚熱下腫、小便難、有余濕	防風湯	平胃丸	滑石散
滑	胸中壅滿吐逆	胃中有熱、食即吐	婦：經脈不利 男：尿血	前胡湯	紫苑湯	朴硝煎、大黃湯
弦	心下怫怫微頭痛	胃寒心下厥逆	心腹痛拘急	甘遂湯	茱萸湯	建中湯
弱	自汗出而短氣	胃虛有客熱	發熱骨煩	茯苓湯	竹葉湯	前胡湯
澀	胃氣不足	血氣逆冷	足脛逆冷小便赤	地黃湯	干地黃湯	附子四逆湯
芤	吐血衄血	大便下血數升	下焦虛、小便出血	竹皮湯	生地黃湯、生竹皮湯	竹皮生地黃湯
伏	噎塞不通	中焦有水氣泄	小腹痛、癰疽、水谷不化	前胡湯	水銀丸	大平胃丸
沉	胸中引脅痛	心下有冷氣苦滿吞酸	腰背痛	澤瀉湯	白薇茯苓丸	腎氣丸
濡	自汗出	虛冷脾熱	小便難	干地黃湯	赤石脂湯	瞿麥湯
迟	心痛咽疼吐酸	胃中寒	下焦有寒	附子湯	桂枝湯	桂枝丸
尖	生熱	胃痛	小腹痛、小便不禁	竹葉湯	梔子湯	當歸湯

(續上表)

虛	生寒			茱萸丸		
細	發熱嘔吐	脾胃虛		黃芩龍胆湯	生薑茱萸蜀椒湯	
洪大	胸脅滿			生薑湯		
牢		脾胃氣寒盛熱，腹滿响响	腹滿陰中急		紫苑丸	葶藶子茱萸丸
洪		胃氣煩滿			平胃丸	

可由脈斷定。“脈經”上有“妊娠四月，左疾為男，右疾為女，俱疾為生二子”的記載，“脈訣”亦直捷地說：“左手帶縱兩個男，右手帶縱

(表三)

發熱性病	病名	症狀	生脈	死脈
發熱性病	傷寒	熱盛	浮大	沉小
	溫病	三四日以下无汗	大疾	細小难得
	熱病	已得汗	靜安	躁
出血性病	吐血衄血		滑小弱	實大
	金創	血出太多	虛細	數實大
	腸澼	下膿血	沉小流連	數疾且大
共	消渴		數大	細小浮短
	咳嗽		浮直軟	沉緊小沉
	瘧疾		弦	大散代
	下利		滑沉弱	強大浮速
	嘔吐		浮滑	沉數澀
	霍亂			代
	喘息		滑	遷四肢寒
	瀕			
他	腹水	腹大如鼓		

一个女；左手脈逆生三男，右手脈順还四女。”至于持“太素脈”者，凡人生的貴賤，寿夭，貧富，僧道，智慧，水火，官祿妻儿等，无一不可占于脈、决于脈，这些更是脈学中的“奇跡”。

但是这些“奇跡”，这些不合理的机械論，不但未足以取信于今日，即古之明达之士，亦曾否定之。如寇宗奭本草衍义：“素問言凡治病察其形气色泽。观人勇怯。骨肉，皮膚，能知其情，以为診法，若患人脈病不相应，既不得見其形，医只据脈供藥，其可得乎。”

吳又可瘟疫論：“夫脈不可一途而取，須知形气神色病症相参，以决安危为善。”

李时珍瀕湖脈学：“世之医病兩家，咸以脈为首务，不知脈乃四診之末，謂之巧者尔，上工欲会其全，非备四診不可。”

第六講 脈搏的性类

在張仲景以前，凡大、小、滑、瀯、浮、沉、迟、数、坚、散、細、弱、緊、虛、実、动、弦、微、結、促、革等脈搏性狀，已分別有記載，应用之于臨床，初无定数，自伪“脈訣”出，捏造了“七表”“八里”“九道”名目，而为“二十四脈”。所謂七表脈，就是浮、芤、滑、実、弦、緊、洪，都为“陽脈”，因为它是“奇”数；所謂八里，就是微、沉、緩、澀、迟、伏、虛、弱，都为“陰脈”，因为它是“偶”数；九道脈，便是長、短、虛、促、結、代、牢、动、細，它的意义更“偉大”，因为“天有九星，地有九州，人有九臟，以应九宮。”李时珍“瀕湖脈学”增列数、微、散三种，而为“二十七脈”（有說李时珍益以長、短、牢三者为二十七非），李中梓的“診家正眼”又增一疾脈，就成了現在的所謂“二十八脈”，危亦林“得效方”本孙思邈死脈之說，又列出“十怪脈”來，其說如下：

彈石——來迟去数，如指彈石。

解索——或聚或散，如繩索之解。

雀啄——來三去一，若雀之啄食。

屋漏——極緩，二息一至。

蝦游——忽有忽无，行屍之候。

魚翔——如魚之搏尾動頭。

釜沸——如釜中沸湯。

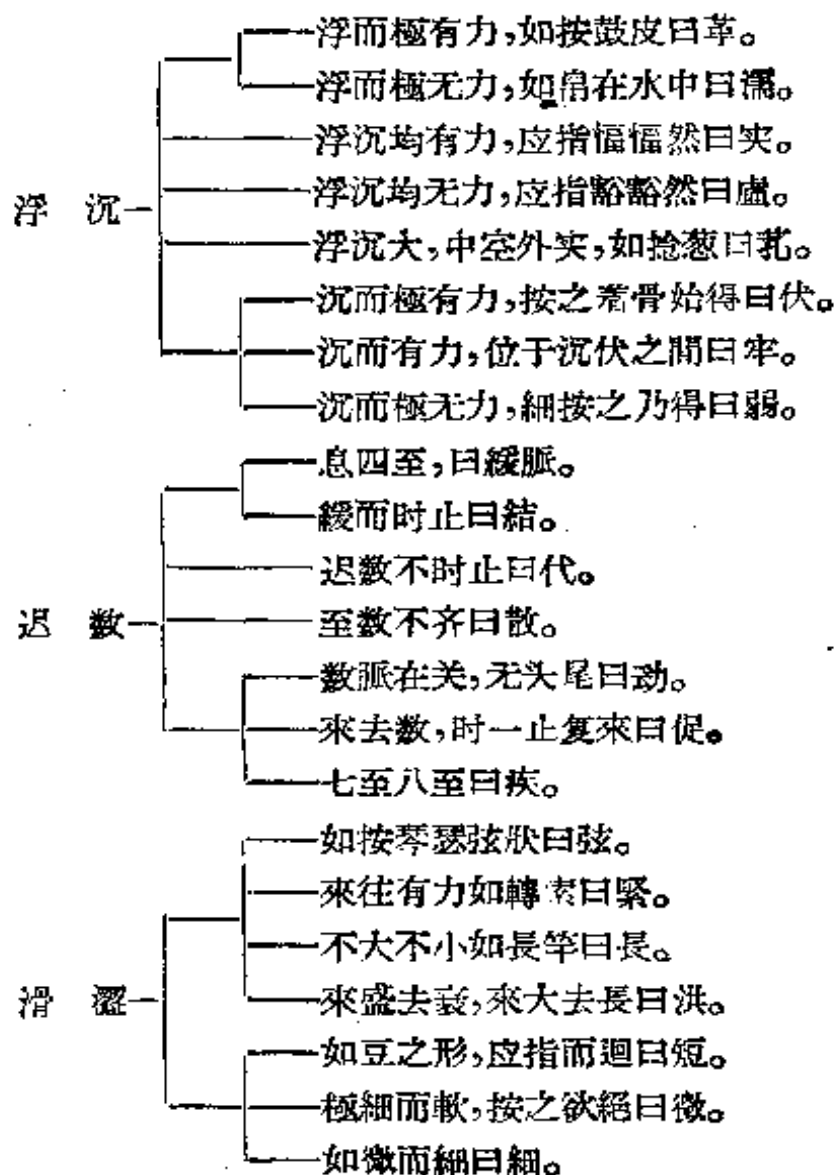
偃刀——如手循刀刃，無進無退。數無准。

轉豆——脈形如豆，周旋展轉，并無息數。

麻促——脈如麻子之紛亂細微。

這些怪脈，一言以蔽之，總是心臟極度衰弱，以及脈管硬變弛縱的征象。假定硬要說出某怪脈主某臟絕，某臟絕要顯示某怪脈，這都不是臨床事實，沒有多大的價值。

脈搏的性類，雖分得這樣複雜，但多半都是空談理論，切合實際應用的並沒有多少。如滑壽的“診家樞要”，他主張分為“浮、沉、遲、數、滑、澀”，六脈，已足應用，其他脈搏的性類，都可以包括在這六脈里面，表釋如下：



陳修園則主張用“浮、沉、迟、數、細、大、長、短”八脈，這些都是“由博返約”的主張，現在一般中醫，不管他對切脈是怎樣的矜持，其臨床應用，也不過就是陳氏主張的八脈罷了。

“七表，八里，九道”，這些理論，我們不必管他，所有“二十八脈”的名狀，究竟怎麼樣呢？茲就主要的幾家的意見，列舉如下：

“浮”：舉之有余，按之不足（脈經）。在肉上行（難經）。

“沉”：重手按至筋骨乃得（脈經）。取于肌肉之下得之（王士亨）。

“迟”：呼吸三至，去來極迟（脈經）。呼吸定息，不及四至而舉按皆迟（張路玉）。

“數”：去來促疾（脈經）。一呼一吸，病者脈來六至（吳山甫）。

“滑”：不澀也，往來流利，如盤走珠（千金）。按之如動珠子（滑伯仁）。

“澀”：往來時不利而蹇澀（王太仆）。脈來蹇澀細而迟，不能流利圓滑（戴同父）。

“虛”：迟大而軟，按之不足，隱指豁豁空（脈經）。無力也，無神也（張介賓）。

“實”：脈之來，舉指有余，按之不乏，浮中沉皆有力而言之也（黎民壽）。

“長”：舉之有余曰長，過于本位亦曰長（高陽生）。

“短”：指下尋之，不及本位（高陽生）。

“洪”：大而實也，舉按皆有余（張介賓）。大而鼓也（吳山甫）。

“微”：似有若无，欲絕非絕，而按之稍有模糊之狀（張路玉）。

“緊”：來往有力，左右彈人手（素問）。如轉索無常（張仲景）。

“緩”：應指和緩，往來甚勻（張太素）。

“芤”：浮大中空，按之如葱管（張介賓）。

“弦”：如琴弦，長過指而有力（嚴三點）。端直以長（素問）。

“革”：如按鼓皮，內虛空而外繃急也（何夢瑤）。

“牢”：按之實強，有似沉伏（千金翼）。按之但覺堅極（楊玄操）。

“濡”：軟脈極軟而浮細（脈經）。虛軟無力，應手細散（滑伯

仁)。

“弱”：極軟而沉細，按之欲絕指下(脈經)。

“散”：渙漫不收(崔紫虛)。來去不明，漫無根底(滑伯仁)。

“細”：形減于常脈一倍曰小(吳山甫)。小大于微，常有，但細耳(脈經)。

“伏”：極重指按之，著骨乃得(脈經)。

“動”：數而跳突名動(何夢瑤)。厥厥然動搖(脈經)。

“促”：促急有來無去(王士亨)。數急時似止而復來(楊仁齋)。

“結”：來去時一止，無常數(難經)。脈來緩，一止復來(張仲景)。

“代”：動而中止，不能自還，因而復動(張仲景)。

(以上二十七脈)

這些脈搏的個別性類，陸淵雷按照西醫切脈的區分，分別歸入至數、調節、性質三科中，“數”“促”“遲”，是屬於脈的至數，“緩”“結”“代”屬於脈的調節，“浮”“芤”“洪”“弦”“緊”“沉”“伏”“革”“牢”“實”“微”“瀼”“細”“濡”“弱”“虛”“散”“動”，都屬於脈的性質，並以“長”“短”二脈，是因體質有肥瘦，血管有顯藏所致，為生理上的殊異，不入于以上三科。為了正確一般對脈搏的認識，勿沉迷于“二十七脈”繁瑣渺茫之中，這是合理的，但除去“長”“短”二脈，便只有二十五脈了。

姜白鷗的主張，二十八脈中能存在者，只有十八脈，如浮、沉、滑、瀼、虛、實、長、短、散、動十脈，皆不足為獨立的脈，他的中醫脈學之檢討說：“浮沉是指醫者切脈而言，滑脈同于洪脈，瀼脈與緩脈類似，虛實是相對的代名詞，長、短、散、動，皆不足以象脈。”能夠存在的十八脈，他都按着血循環的生理，分類區別如下：

(一)心臟排水量之關係：

排水量充實者——洪脈。

排水量小弱者——芤脈、微脈、弱脈、瀼脈。

(二)血管之關係：

脈管粗而排水量充實者——洪脈。

脈管細而排水量充實者——弦脈。

脈管緊張程度減低者——濡脈。

脈管纖微萎縮及變硬者——緊脈、革脈。

血管收縮者(末梢動脈收縮)——弦脈、遲脈。

血管擴張者(末梢動脈擴張)——數脈、洪脈。

(三) 心動速度之關係：

心動弛緩者——遲脈。

心動亢進者——數脈。

(四) 血壓之關係：

血壓亢進者——牢脈。

血壓低降者——濡脈。

(五) 心臟組織機能障礙之關係：

僧帽瓣口狹窄，心力衰弱者——濡脈、伏脈、細脈。

大動脈瓣閉鎖不全者——疾脈。

大動脈瓣口狹窄者——緩脈。

瓣膜閉鎖不全者——促脈、結脈、代脈。

血管栓塞者——促脈、結脈、代脈。

姜氏之說，固不無見地，但因脈管擴張，有多量血液流向表層的時候，何嘗不可以見到浮脈。又如內部動脈充血、致淺層動脈貧血的時候，又何嘗不可以見到沉脈。前者屬於西醫“大脈”之類，后者屬於西醫“小脈”之類。滑脈亦等於西醫的“疾脈”，不是因于脈管的縮張皆速，便是由于大動脈瓣閉鎖不全而心臟肥大的原故。瀉脈亦等於西醫的“徐脈”，多由于動脈硬化而脈管的彈力減少，或脈管緊張過甚，減少彈力，而致脈搏擴張徐緩的原故。脈管弛緩且血少，心力弱，血壓低，其脈必“虛”，猶西醫的“軟脈”，血液充盈而血壓高漲者，其脈必“實”。使血管神經失其緊張而緩縱，便成“散脈”。疾脈的重复見，便成“動脈”，姜氏一概棄而不談，這是偏見。

總之，二十八脈，分類多而不精切，許多都是重复見的，甚至有的是空談、臆度，西醫有一時期亦犯了这个毛病，列了許多脈名，今已棄而不用，這不能不算是他們的進步。

第七講 切 脈 法

由于过去对脈搏認識不夠正确，“上焉者”倚重脈法，穿鑿附会，翫翫以为神奇；“下焉者”虽沒有十分本領，然而他伸出三个指头，按着病人桡骨动脉，凝神壹志似的，儼然洞知癥結，裝出“十分高明”的样子，照規矩“男左女右”（元滑寿曾有此說），即是男性病人一定先要看左手，女性病人一定先要看右手，假如男性病人先伸出右手來“看”（切的意思），“先生”要罵你不懂規矩，女性病人先伸出左手來“看”，同样的也要被罵。如当“先生”的不講究“男左女右”，被“同行”知道了，也要受到非議。这是由于封建社会的習俗使然，于医学上是沒有什么关系的。

切脈時間：一般是有病便診，这是对的，在古人則以“平旦”最好，例如素問脈要精微論：“黃帝問曰：診法何如？岐伯对曰：診法常以平旦，陰气未动，陽气未散，飲食未進，脈經未盛，絡脈調勻，气血未乱，故乃可診有过之脈。”

平旦切脈固然好，但不能把每个病人，不分緩急的都固定在平旦來診斷。至于說：“飲食未進，气血未乱”等，到有相当的理由，值得注意。例如在食后，或者是在飽食以后，或者是攝取了滾热的飲食料，在一二小时中，脈搏是一定会增加的，絕食时則減少。身体运动，也常使脈搏至数增加，甚至僅变动位置，即受其影响。平臥时脈数最減，端坐起立，脈数較增加，如重病恢复期的病人，受影响为尤鉅，僅使其在牀上起坐，便見脈搏顯著的增進。所以切脈而候其至数，以仰臥的位置为最好。而一般中医切脈，則往往与此相反，就是臥床不起的病人，亦必勉強扶掖之而起，端坐切脈，这不怕“乱其气血”嗎？——

切脈的至数，中医都是憑自己的呼吸，來測知病人脈搏至数的多寡，內經素問平人氣象論說：“黃帝問曰：平人何如？岐伯对曰：人一呼脈再动，一吸脈亦再动，呼吸定息，脈五动，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也，常以不病調病人，医不病，故为病人平息以

調之，為法。”

董西園說：“一息中得四至之半，乃為和平之脈。”張路玉說：“數脈者，呼吸定息，六至以上而應指急數。”于是一般中醫呼吸定息，都以一息五至為平脈，以呼吸每分鐘十六次計之，則一息五至，每分鐘便八十至。求之實際，健康人脈搏至數，一分鐘平均在七十至七十六至之間，這亦不差上下，但古人限于時代環境，沒有鐘表器具，呼吸定息，未嘗不可，今日鐘表普遍，仍以時表計算，最為合宜，不然，便如余云岫百之齋隨筆所說：“以不病之人調有病之人，故必須醫者不病，然後可以調病人之息及脈，若醫者自己有病，即不能調矣。況平人之息亦有少異，甲醫以其息調此病人之脈，乙醫亦以其息調此病人之脈，甲乙兩醫之息異，則其所得之脈亦異，安能得正確之數乎？楊上善註太素曰：‘平人脈法，先醫人自平，一呼脈再動，一吸脈亦再動，是醫不病，調和脈也。然後數人之息，一呼脈再動，一吸脈再動，即是彼人不病者也。’是楊氏之意，乃謂以病人之息調病人之脈矣，其所得者只脈與息之相應與否，而病人之息，病人之脈之異于平人與否，不可得而定也。余嘗視一病重，其體溫在攝氏四十度左右，其脈在一分鐘內為七十二至，其病為腸傷寒，若僅以脈論，其至數與平人無異，然以脈與體溫之相應論之，則脈遲矣。蓋依常法，大約體溫增高攝氏一度，脈數當增多八至也，而醫家脈案，皆書脈數，豈非大謬，知舊醫視脈之標準，疏漏不可恃如此，由其用主觀故也。”

時表是客觀的器械，所以我們切脈，最好用它來作標準計算。

切脈還有所謂“手法”，這也是有些中醫最矜持的，但也奇怪，在前輩人中也就有这样的矜持了：如朱奉議活人書說：“凡初下指，先以中指端按關位，掌后橈骨為關，乃齊下前後二指，為三部脈，前指寸口，后指尺部也。若人臂長乃疏下指，臂短則密下指。”

汪石山脈訣刊誤附錄說：“揣得橈骨，壓中指于高骨，以定關位，然後下前後二指，以定尺寸，不必拘一寸九分之說也。”

楊仁齋察脈真經說：“关于部位，其肌肉隱隱而高，中取其關而上下分之，則人虽長短不謀，而三部之分，亦隨其長短而自定。是必先按寸口，次及于關，又次及尺。”

王士亨全生指迷方說：“寸关尺在腕上側，有骨稍高曰高骨，以中指按骨，搭指面落處謂之關，前指為寸部，後指為尺部。”

滑伯仁診家樞要說：“凡診脈之道，先須調平自己氣息，男左女右，先以中指定得關位，却齊下前後二指。”

這些都是一致主張切脈須用三指，先以中指定高骨，再下先後二指，惟楊仁齋主張先下示指（先按寸口），次下中指（次及于關）次下環指（又次及尺），這樣依次順序下指，其實這是不用爭論的，先下後下，其下一也。在前面已經說了“寸、關、尺”是假設的，就用兩個指拇，也未嘗不可。一般的脈搏，兩只手都差不多的，只看左右任何一只手都可以（一般看右手），必要時亦得看左右兩手，但如滑伯仁所謂“男左女右”，那又是無稽之論。

以上“定指”，是切脈“手法”之一，定指以後，在切按時又有手法了，如楊仁齋察脈真經說：“每部下指，初則浮按消息之，次則中按消息之，又次則沉按消息之……于是舉指而上，復隱指而下，又復撈相進退，心領意會，十得八九，然後三指齊按，候其前後往來，接續間斷如何耳。”

滑伯仁診家樞要說：“初輕按以消息之，次中按消息之，然後自寸關至尺，逐步尋究。”又曰：“持脈之要有三：曰舉、曰按、曰尋、輕手循之曰舉，重手取之曰按，不輕不重，委曲求之曰尋。”

汪石山脈訣刊誤說：“按消息，謂詳細審察也，推，謂以指挪移于部之上下而診之，以脈有長短之類也。又以指挪移于內外而診之，以脈有單弦雙弦之類也，又以指推开其筋而診之，以脈有沉伏止絕之類也。”

凡切脈只將手指輕貼桡骨動脈上，不用力壓，便是正法，以上諸家臆說，徒亂人意耳。廖平對切脈評議，頗多精當語，值得介紹給一般中醫們作參考，如評朱奉義三指說云：“古法診脈只用一指，或用全手如捫循，凡用三指者皆偽法。”

評朱奉義、汪石山：“案二說原于脈經分別三關境界，脈候篇此書既不同三部說，一指可也，既不分左右男女，各診一手可也，有此思想，然後可徐引之于道。”

評楊仁齋：“既不用兩手三部之法，則如少陰人迎，一指診之

足矣，何以仍采三指三部之說耶。”

評滑伯仁：“九候云獨大獨小，獨徐獨疾者病，謂遍診九穴，其穴異常，即為病脈，乃與別部比較，非于一部之中強立名號。”

評滑伯仁：“于寸口一部，以浮沉分臟腑，又以浮中沉分占五臟位次，全出難經，皆為魔語。”

評汪石山：“四診心法云：脈只有一條，弦之名詞，已屬誤解，更造單雙弦之說，使人迷惘，真以魔術魔人。”

評張景岳：“古法只用一指專診各穴，如以人寸少陰三部言，三部形狀，迥然不同，比較自易，兩寸同為太陰脈，既不別左右，又不分關尺，一指診之，何等簡易。今于一脈之中，強分左右，又分三部，一部之中又分臟腑下指，莫不迷惘，學者苟不自欺，則莫不以診脈為苦。”

又評張景岳：“診脈必明白淺易，老嫗可解，初學能行，掃除一切悠謬迷惘之言，非彰明古法，簡而能博，易記難忘，不足以明經立教。”

第八講 張仲景脈法（上）

時下一般中醫講“脈法”，文化水平較高的，都去鑽“內經”“難經”“脈經”，以為這些是講脈法的根底書籍。不錯，這些“經”固然是脈經的濫觴者，或作俑者，即或一成不變，他們局限于當時那個時代，其最高的理論，也不過是以上綜述那些；而況時有蛻變，屢有雜譯，已經大部份是換形脫骨，一再變質了。其次便是讀俚俗的脈訣，很機械地搬來硬套，更沒有多大價值。其實真要反求諸古，張仲景的脈法（不包括世傳傷寒偽本的“平脈法”等）到是一部比較近情合理的脈書，仲景切脈，他自己也說是撰用素問九卷，可見他的根據，同樣出于內經，但他當時去古未遠，所見到的素問，當然要詳實可靠一些，他又說：“平脈辨証，為傷寒雜病論。”可見他是理論與經驗結合的實踐者，既能批判地接受理論，復能靈活地運用于臨床，所以“傷寒論”和“金匱要略”兩書，是診斷和治療相互結合的

实况实錄，兩書中对每一类病症，都叫做“病、脈、証并治”，决不类于一般憑空臆說的脈書，也即是說他平脈和辨症是并重的，是相依为用的，他决不孤立的武断的僅憑脈而“神乎其技”，他对于切脈的灵活应用，主要發揮在下列几方面：

(一)病机轉变的窺測：人体上發生了病变，緊随着病变而來的，也必然要發生一种应付这病变的抗体，抗体能够应付病变，必然獲得好的轉归，也就是疾病会被抗体消滅。如抗体不足以应付，那末疾病的机轉，將勝利地开展下去，而抗体乃告失敗，抗体和病变孰勝孰敗，对于心臟的強弱，血循环的亢進和衰減，是有相当关系的。心臟強，血循环机能亢進，則細胞生活上需要的营养素和酸素有所补給，組織細胞產生的种种廢物，如炭酸、尿酸鹽等有所排除，防御病害的各种抗体，以及內分泌腺產生的內泌素等，也有很好的运输，而繼續对疾病發生抵抗作用，以至獲得最后勝利，并重新建設，恢复健康。反之，心臟不好，甚至血循环起退行的变化，是无法战胜疾病，必將每况愈下的。如伤寒論辨太陽病脈症并治：“伤寒一日，太陽受之，脈若靜者，为不傳；頗欲吐，若躁煩，脈数急者，为傳也。”这是病輕，体力适应裕如，脈搏很正常的工作着，知道这病变机轉不会發展下去的，是为“脈靜不傳”。假如有欲吐、躁煩等現象，交感神經也兴奋，脈搏加速而“数急”，这說明病勢重篤，原因复雜，不單純是“太陽病”（太陽病不吐不煩），疾病的机勢还在往下發展，所以說：“頗欲吐，若躁煩，脈数急者，为傳也。”又如伤寒論辨太陽病脈症并治上：“太陽中風，陽浮而陰弱，陽浮者，热自發，陰弱者，汗自出，齋齋惡寒，淅淅惡風，翕翕發熱，鼻鳴干嘔者，桂枝湯主之。”所謂“陽浮陰弱”，即輕按脈搏，便得浮象，重按之，便覺緩弱无力。为什么从“陽浮”便知其要發熱，“陰弱”便要出汗呢？因为淺層動脈充血，脈必見浮，既已充血，体温將隨之而升高發熱；淺層動脈神經弛緩，重按脈搏，即可觸知其不很緊張而緩弱，淺層動脈神經既已弛緩，則肌膚里的汗腺，亦將受其影响而弛緩放汗，这都是体力适应病变的一种必然趨勢。又如伤寒論辨太陽病脈症并治上：“太陽病，得之八九日，如瘧狀，發熱惡寒，热多寒少，其人不嘔，清便欲自可，一日二三度發，脈微緩者，为欲愈也。脈微而惡

寒者，此陰陽俱虛，不可更發汗、更下、更吐也。面色反有熱色者，未欲解也；以其不能得小汗出，身必癢，宜桂枝麻黃各半湯。”病了八九天，每天經過二三度發熱惡寒的發作，但是並沒有現其他的雜症（不嘔，清便自可），脈管自然不能有適量的緊張而“微”，但其搏動的調節均勻而“緩”，這說明病者的體力還很正常，容易恢復健康。如脈搏微弱，不惟不帶調節停勻的“緩”象，反而繼續惡寒，這說明是心臟衰弱，血液不足，體溫過低的“陰陽俱虛”現象。若面色潮紅，這是體溫郁結，未得放汗自散，宜其皮下發癢。

（二）治療方法的確定：脈搏既能直接窺測心臟和血循環的健全與否，間接也能測知疾病的趨勢，和抗力的亢進與衰減，在這中間辨認清楚了，對於治療的確定，是有一定的幫助的。張仲景于此尤有不少的寶貴經驗，試舉傷寒論中數條為例，辨太陽病脈症并治上：“桂枝本為解肌，若其人脈浮緊，發熱汗不出者，不可與之也，當須識此，勿令誤也。”皮膚縮而汗孔閉，體溫也不能照常放散，便成“發熱汗不出”的症候。淺層動脈神經，因隨着皮膚汗腺而收縮，但血液則反因高溫繼續充盈不已，脈搏必然會觸切到“浮緊”的現象，這時切要之圖，只有發汗以放散體溫，宜麻黃湯之類，桂枝湯是不中用的。

但是切脈對確定治療的幫助，並不是決定性的，也不可能有決定性，所以張仲景說：“觀其脈証，知犯何逆，隨証治之。”決不是孤立的“隨脈治之”，傷寒論里面有這樣兩條：

辨太陽病脈症并治上：“服桂枝湯，大出汗，脈洪大者，與桂枝湯，如前法。若形如瘧，一日再發者，汗出必解，宜桂枝二麻黃一湯。”

又說：“服桂枝湯、大汗出後，大煩渴不解，脈洪大者，白虎加人參湯主之。”

放溫機能亢進的“大汗出”症，桂枝湯症和白虎湯症都有，由於心機亢進而脈管充血的“洪大”脈，只見於白虎湯症而不見於桂枝湯症，惟白虎湯症還有其一個主要的症候，是唾腺粘膜分泌缺乏的“煩渴”，因此，前一條沒有白虎湯的“煩渴”主症，張仲景便不憑脈而憑証，用桂枝湯；後一條白虎湯的主症具備，便用了白虎湯，這說

明診斷上的辨症重于平脈，这也說明張仲景是决不孤立的憑脈斷症而確定治療的。正因為不孤立的憑脈，而灵活的平脈辨証，反能相得益彰，有助於治療的確定。如辨太陽病脈症并治中：“傷寒十三日，過經譫語者，以有熱也，當以湯下之。若小便利者，大便當鞏，而反下利，脈調和者，知醫以丸藥下之，非其治也；若自下利者，脈當微厥，今反和者，此為內實也，調胃承氣湯主之。”患傷寒十多天，因高熱而神經錯亂譫語，用承氣湯之類瀉下大便，減輕溫度，這是合理的，今病人大便已經瀉下，又不見高熱的脈搏，這是前醫用的丸子下藥不好，沒有把神經鎮靜下來，從他脈搏很正常這方面看，知道其體溫也不高，只是胃腸里的毒物未能清滌干淨，宜用調胃承氣湯以清滌胃腸，安靜神經，止其譫語。這是因為平其脈搏，知道沒有高熱，所以不用大清涼的藥劑。

(三)預后的推測：脈搏對於預后的關係，已如第五講所說，尤其是診察熱性諸病，是未容忽視的。張仲景對於預后脈搏的診察，亦有很好的經驗。如傷寒論辨少陰病脈症并治：“少陰病，下利脈微者，與白通湯。利不止，厥逆無脈，干嘔煩者，白通加豬胆汁湯主之，服湯脈暴出者死，微續者生。”心臟已衰弱至不能搏動，因被強心劑的刺激而脈搏“暴出”，這不過是暫時的搏動一下，藥力消逝了，心臟終於要停止下來而歸于不治。假如是由于心臟機能的“自力更生”，緩緩的恢復了他固有的唧血筒作用，它的搏動是由漸而微的，這才是它“東山再起”“捲土重來”本能的自然康復，那末病機一定有良好的轉歸，這確是老子臨床的經驗之談。又如傷寒論辨厥陰病脈症并治：“傷寒下利日十余行，脈反實者死。”這是由于心臟的虛性興奮，最后掙扎而顯現的脈搏，心臟終於會愈益陷于疲憊而不救的，這種脈搏，但覺血液在血管中勁疾直前，不復有波動起落，因為脈管已失掉了彈力，而心臟僅作最后的虛性興奮罷了。

根據以上所引的例子（同樣的例子當然還多），張仲景的平脈辨証，在臨床上是脈與証分不開的，而且是相依為用的。所以他記載那么多的病例，都有理論、有經驗（當然不包括后人的偽雜條文），決非難經、脈經這些徒託空談的可以比擬。因此，中醫還在施用對症療法的今天，張仲景所累積下來那些平脈辨症的經驗和方

法的实例，是值得我們學習的唯一的脈学讀物。

茲將張仲景伤寒金匱兩書所有的脈法，分別类列于后，以見一般：

(1) 数 脈

辨太陽病脈症并治中第一二九条：“病人‘脈数’，‘数’为热，当消穀引食，而反吐者，此以發汗，令陽气微，膈气虛脈乃‘数’也，‘数’为客热，不能消穀，以胃中虛冷，故吐也。”

辨陽明病脈症并治第二六三条：“病人无表里症，發熱七八日，虽脈浮数者，可下之，假令已下，‘脈数’不解，合热則消穀善飢，至六七日，不大便者，有瘀血，宜抵当湯，若‘脈数’不解，而下不止，必协热便膿血也。”

辨厥陰病脈症并治第三三六条：“伤寒始發熱六日，厥反九日而利，凡厥利者，当不能食，今反能食者，恐为除中，食以索餅，不發熱者，知胃气尚在，必愈。恐暴热來出而复去也。后三日脈之，其热續在者，期之旦日夜半愈，所以然者，本發熱六日，厥反九日，复發熱三日，并前六日，亦为九日，与厥相应，故期之旦日夜半愈。后三日脈之而‘脈数’，其热不罢者，此为热气有余，必發癰膿也。”

辨厥陰病脈症并治第三六五条：“下利‘脈数’，有微热汗出，令自愈，設复紧，为未解。”

辨厥陰病脈症并治第三七二条：“下利‘脈数’而渴者，令自愈，設不差，必清膿血，以有热故也。”（以上伤寒論）

百合狐惑陰陽毒病脈症并治第五六条：“病者‘脈数’，无热微煩，默默但欲臥，汗出，初得之三四日，目赤如鳩眼，七八日，目四眇黑，若能食者，膿已成也，赤小豆当归散主之。”

肺痿肺癰咳嗽上气病脈症并治第九九条：“問曰：热在上焦者，因欬为肺痿，肺痿之病，从何得之？师曰：或从汗出，或从嘔吐，或从消渴，小便利数，或从便难，又被快藥下利，重亡津液，故得之，曰：寸口‘脈数’，其人欬，口中反有濁唾涎沫者何？师曰：为肺痿之病，若口中辟辟燥，欬即胸中隱隱痛，脈反滑数，此为肺癰，欬唾膿血，脈数虛者为肺痿，数实者为肺癰。”

肺痿肺癰咳嗽上氣病脈症并治第一一〇條：“欬而胸滿，振寒‘脈數’，咽干不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿，如米粥者，為肺癰，桔梗湯主之。”

消渴小便利淋病脈症并治第二二一條：“趺陽‘脈數’，胃中有熱，即消谷引食，大便必堅，小便即數。”

水氣病脈症并治第二三三條：“趺陽脈當伏，今反‘數’，本自有熱，消谷小便數，今反不利，此欲作水。”

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈症并治第二八六條：“夫吐血，欬逆上氣，其‘脈數’而有熱，不得臥者死。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三〇〇條：“問曰：病人‘脈數’，‘數’為熱，當消谷引食，而反吐者何也？師曰：以發其汗，令陽微膈氣虛，脈乃‘數’，‘數’為客熱，不能消谷，胃中虛冷故也。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三二五條：“下利‘脈數’，有微熱汗出，令自愈，設脈緊，為未解。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三二六條：“下利‘脈數’而渴者，令自愈，設不差，必清膿血，以有熱故也。”

瘡癰腸癰浸淫病脈症并治第三四七條：“腸癰之為病，其身甲錯，腹皮急，按之濡，如腫狀，腹無積聚，身無熱，‘脈數’此為腸內有癰膿，薏苡附子敗醬散主之。”

婦人雜病脈症并治第三九二條：“婦人之病，因虛積冷結氣，為諸經水斷絕，至有歷年血寒，積結胞門，寒傷經絡，凝堅在上，嘔吐涎唾，久成肺癰，形体損分，在中盤結，繞臍寒疝，或兩脅疼痛，與藏相連，或結熱中，痛在關元；‘脈數’無瘡，肌若魚鱗，時着男子，非止女身。”（以上金匱要略）

所謂數脈，就是脈搏的搏動頻數，這是與減少的脈搏相對立的，中醫以息平脈，凡一息六至以上便是數脈，（一息六至，約為每分鐘九十六至，七至約為百一十二）一般以數脈為有熱，這不可一概而論，惟熱性諸病，往往有數脈就是了。原因為高热或細菌毒素持久的刺激心肌及交感神經中樞，使迷走神經麻痺，而心臟以無禁地衝動，致交感神經異常興奮，隨見心動亢進而使之然。“數為熱”，“脈數其熱不罷”，“脈數有微熱汗出”，“其脈數而有熱”諸條，

都是屬於熱性諸病的數脈，反乎此，雖然熱度高，而因其生理病理的關係，脈搏也會不數而徐緩，如傷寒論辨厥陰病脈症并治第三三七條說：“傷寒脈遲六七日，而反與黃芩湯徹其熱，脈遲為寒，今以黃芩湯復除其熱，腹中應冷，當不能食，今反能食，此名除中，必死。”就是明証。同時，又與此相反，并無熱型，而脈搏也能見數的，“今陽微，膈氣虛，脈乃數也。”“振寒脈數。”“病者脈數，無熱微煩。”“身無熱，脈數，”諸條均是，凡熱性病于虛脫時，體溫雖較常下降，其脈搏往往數且小，這是由于心臟衰弱或麻痺的原故。一切疼痛性病及驚愕畏怖等，脈搏亦常見頻數，肺癰，腸癰，婦人雜病諸條的脈數，應屬於這一類。

(2) 數 急 脈

辨太陽病脈症并治上第四條：“傷寒二日，太陽受之，脈若靜者為不傳，煩欲吐，若躁煩，‘脈數急’者，為傳也。”

數急，是頻數度還大的脈搏，當在百至或百二十至左右，體溫當在高熱時期，這是由于交感神經興奮，心動亢進，體溫和脈搏比例上升所致。這說明病勢還在前進，所以叫做“傳。”

(3) 遲 脈

“辨太陽病脈症并治中第五二條：“脈浮緊者，法當身疼痛，宜以汗解之，假令尺中‘遲’者，不可發汗，何以知然？以營氣不足，血少故也。”

辨太陽病脈症并治下第一五一條：“婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得之七八日，熱除而‘脈遲’身涼，胸脅下滿，如結胸狀，譫語者，此為熱入血室也，當刺期門，隨其虛而取之。”

辨陽明病脈症并治第二〇四條：“陽明病‘脈遲’，食難用飽，飽則微煩頭眩，必小便難，此欲作谷瘕，雖下之，腹滿如故，所以然者，‘脈遲’故也。”

辨陽明病脈症并治第二一七條：“陽明病‘脈遲’，雖汗出，不惡寒者，其身必重，短氣腹滿而喘。”

辨陽明病脈症并治第二四〇條：“陽明病‘脈遲’汗出多，微惡

寒者，表未解也，可發汗，宜桂枝湯。”

辨厥陰病脈症并治第三三七条：“伤寒‘脈迟’，六七日而反与黄芩湯徹其热，‘脈迟’为寒，今以黄芩湯复除其热，腹中应冷，当不能食，今反能食，此名除中，必死。”（以上伤寒論）

黄疸病脈症并治第二六一条：“陽明病‘脈迟’者，食难用飽，飽則發煩头眩，小便必难，此欲作谷疸，虽下之，腹滿如故，所以然者，‘脈迟’故也。”

妇人雜病脈症并治第三八七条：“妇人中風，發热惡寒，經水適來，得七八日，热除‘脈迟’身涼和，胸脅滿，如結胸狀，讞語者，此为热入血室也，当刺期門，随其穴而取之。”（以上金匱要略）

一息不及四至，便是迟脈，就是脈來的搏动很迟緩。凡迷走神經兴奋，必致心动弛緩，而心动迟緩的結果，脈搏便迟。如脂肪心、腦疾患、黄疸、大動脈口狹窄、鉛及酒精中毒、急性热病分利后，以及下腹臟器之疼痛性等病，都往往見迟脈，迟脈的見症，一般为血压低降，体温低落，体力衰弱等，因为体力衰弱了，所以“尺中迟者，不可發汗”，因为体温低降，所以“热除而脈迟身涼”，这些都是以脈迟为寒的根据。然而也有热性病而脈迟的，已如前述，如妇人中風的脈迟，伤寒黄芩湯的脈迟，都是有热型的，这是由于高温灼刺神經，或由于病原体毒素刺激迷走神經而兴奋的原故。陽明病的脈迟，应多属于这一类。

(4) 迟 浮 弱 脈

辨太陽病脈症并治中第一〇三条：“得病六七日，‘脈迟浮弱’，惡風寒，手足溫，医二三下之，不能食，而脅下滿痛，面目及身黃，頸項強，小便难者，与柴胡湯，后必下重。”（伤寒論）

这是心动弛緩而心力又頗衰弱的脈搏，但病是有胃腸炎症的情况，这当舍脈从症。

(5) 迟 緊 脈

瘡癰腸癰浸淫病脈症并治第三四八条：“腸癰者，少腹腫痞，按之即痛如淋，小便自調，时时發热，自汗出，复惡寒，‘其脈迟緊’

者，膿未成，可下之，當有血。”（金匱要略）

心動弛緩，而脈管壁的收縮神經又興奮，則見遲緊脈，這與疼痛性病有關係，但不能根據脈的遲緊，而便斷其膿未成。

(6) 遲 滑 脈

金匱嘔吐噦下利病脈症并治第三三五條：“下利‘脈遲而滑’者，實也，利未欲止，急下之，宜大承氣湯。”

心動雖然弛緩，而脈管的縮張確速，便見遲滑脈，這就是脈搏的至數雖不足，而每至的起止，却有躁急之象，身體素弱而患熱性病的人，多見這樣的脈象。

(7) 遲 澹 脈

金匱水氣病脈症并治第二五六條：“師曰：寸口‘脈遲而澹’，遲則為寒，澹為血不足。”

遲澹脈是由于心臟的速度不足，脈管的彈力亦復減少而致，所謂寒，即指心臟機能衰減，所謂血不足，應為脈管彈力的減少，並不是由于血液的量少了。

(8) 遲 緩 脈

金匱中風歷節病脈症并治第六七條：“寸口‘脈遲而緩’遲則為寒，緩則為虛，營緩則為亡血，衛緩則為中風，邪氣中經，則身痒而癢疹，心氣不足，邪氣入中，則胸滿而短氣。”

遲緩脈，當為一息四至脈，是遲脈的比較好者，即是說心動雖弛緩而不甚，寒云虛云，當為脈經家言，非仲景意。

(9) 促 脈

辨太陽病脈症并治上第二三條：“太陽病，下之後，‘脈促’胸滿者，桂枝去芍藥湯主之。”

辨太陽病脈症并治上第三六條：“太陽病，桂枝証，醫反下之，利遂不止，‘脈促’者，表未解也，喘而汗出者，葛根黃芩黃連湯主之。”

辨太陽病脈症并治下第一四七条：“太陽病，下之，其‘脈促’，不結胸者，此為欲解也。”

辨厥陰病脈症并治第三五三条：“傷寒‘脈促’，手足厥逆者，可灸之。”（以上傷寒論）

促脈的原因有三：（一）心臟張縮，自有間歇。（二）心臟衰弱，不能充分噴射血液于橈骨動脈。（三）瓣膜的閉鎖不全，以及血管的栓塞。仲景所經驗的促脈四條，大半都是占驗于下利后，是體力尚未至于十分衰弱之征。王叔和說：“脈來數，時一止復來，名曰促。”是明明說促脈止而復來，大有卷土重來，重整旗鼓之勢，故手足雖至厥逆，其脈促者，還可用灸法，以興奮其機能，助其自然療能的恢復。

（10）緩脈

辨太陽病脈症并治第二條：“太陽病，發熱汗出，惡風‘脈緩’者，名曰中風。”

緩脈是平等整齊，脈搏調節的常態脈，太陽中風，雖然發熱，但經過出汗，體溫仍不很高，脈搏的調節也就沒有受其影響而緩。姜白鷗謂大動脈瓣口狹窄者，其脈必緩，他把緩脈和瀉脈看成一類型，十年前余亦從其說，但于仲景驗案中無根據，臨床上亦殊不爾。

（11）結脈

辨太陽病脈症并治下第一八六條：“脈按之來緩，時一止復來者，名曰‘結’，又脈來動而中止，更來小數，中有還者反動，名曰‘結’，陰也。”

凡體溫低降，靜脈的還流減少，心臟的搏動失去平衡，便于遲緩中頻見息止，而少頃又來搏動着的結脈，所以閻德潤以為就是現在所謂的“不整脈”。

（12）代脈

辨太陽病脈症并治下第一八六條：“脈來動而中止，不能自還，因而復動者，名曰‘代’，陰也，得此脈者，必難治。”

凡神經衰憊，心臟搏動時有間歇性的休止，便是代脈，相當于過去西醫所稱的“互脈”，這是體力衰憊不振的象徵，所以為難治。

(13) 結代脈

辨太陽病脈症并治下第一八五條：“傷寒‘脈結代’，心動悸，炙甘草湯主之。”

陸淵雷說：“一止之後繼以特殊數脈，一若補償前一止之搏動者，是為結，所謂自還也；一止之後，繼來不數，無以補償者，是為代，所謂不能自還也。”（診斷治療）又說：“血液虛少，血壓有低落之虞，心臟起代償性搏動興奮，故一方面自覺心悸亢進，一方面因血液不能充盈其脈管，心房雖大起大落，其搏動不能依次傳達于橈骨動脈，故脈有結代也。”總之，結代脈，便是有間歇性的脈搏，其間歇間的為結為代，須老于臨床有經驗的，才能了然。

(14) 大脈

辨陽明病脈症并治第一九五條：“傷寒三日，陽明‘脈大’。”

辨厥陰病脈症并治第三七〇條：“下利脈沉弦者，下重也，‘脈大’者，為未止。”（以上傷寒論）

瘧濕喝病脈症第三五條：“濕家病，身疼發熱，面黃而喘，頭痛鼻塞而煩，其‘脈大’，自能飲食，腹中和無病，病在頭中寒濕，故鼻塞，內藥鼻中則愈。”

血痹虛勞病脈症并治第八二條：“夫男子平人，‘脈大’為勞，極虛亦為勞。”

血痹虛勞病脈症并治第九〇條：“人年五六十，其病‘脈大’者，痹俠背行，若腸鳴，馬刀俠癭者，皆為勞得之。”

嘔吐下利病脈症并治第三二二條：“下利脈沉弦者，下重，‘脈大’者，為未止。”（以上金匱要略）

神經弛緩：脈管擴張，脈的搏動自大，如脈管血液充盈，因被动地擴張；這種大脈，象徵着體力的亢進，如“陽明脈大”“脈大為未止”，都屬於這一類；如由于脈管失却彈力，因自動地擴張，這種大脈，是軟弱性的，“脈大為勞”“脈大者痹俠背行”便屬於這一類。

“湿家病脉大”，为流行性感冒，是發熱而充血旺盛的大脈。

(15) 大 緊 脈

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一四五条：“‘脈大而緊’者，陽中有陰，可下之。”（金匱要略）

脈管虽萎縮，而血行頗亢奮，便見大而緊的脈搏。

(16) 洪 大 脈

辨太陽病脈症并治上第二七条：“服桂枝湯，大汗出，‘脈洪大’者，与桂枝湯如前法，若形如瘧，一日再發者，汗出必解，宜桂枝二麻黃一湯。”

辨太陽病脈症并治上第二八条：“服桂枝湯，大汗出后，大煩渴不解，‘脈洪大’者，白虎加人參湯主之。”（以上傷寒論）

趺蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘虫病脈症治第三五七条：“問曰：病腹痛有虫，其脈何以別之？師曰：腹中痛，其脈当沉若弦，反‘洪大’，故有蚘虫。”（以上金匱要略）

体温昇騰，心机亢進，血流加速，血压增高，末梢的動脈充血，勢必見洪大的脈搏，服桂枝湯兩条的脈搏洪大，便是由于造溫机能的亢盛，心房的張縮力強而速，淺層動脈擴張的原故。至洪大脈是有蚘虫的象征，于學理于經驗，都无憑据，恐仲景不会書此。

(17) 洪 數 脈

瘡癰腸癰浸淫病脈症并治第三四八条：“腸癰者，少腹腫痞，按之即痛如淋，小便自調，时时發熱，自汗出，复惡寒，其脈遲緊者，膿未成，可下之，当有血，‘脈洪數’者，膿已成，不可下也，大黃牡丹湯主之。”（金匱要略）

患盲腸炎的脈搏已見洪數，是炎症蔓延，病机尚趨于亢進中，大有潰膿的象征。

(18) 浮 脈

辨太陽病脈症并治上第一条：“太陽之为病，‘脈浮’头項強痛

而惡寒。”

辨太陽病脈症并治上第七條：“若發汗已，身灼熱者，名風溫，風溫為病，‘脈陰陽俱浮’，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，語言難出。”

辨太陽病脈症并治上第三一條：“傷寒‘脈浮’，自汗出，小便數，心煩，微惡寒，脚攣急，反與桂枝湯，欲攻其表，此誤也，得之便厥。”

辨太陽病脈症并治中第三九條：“太陽病，十日以去，脈浮細而嗜臥者，外已解也，設胸滿脅痛者，與小柴胡湯；‘脈但浮’者，與麻黃湯。”

辨太陽病脈症并治中第四七條：“太陽病，先發汗不解，而復下之，‘脈浮’者不愈，‘浮’為在外，而反下之，故令不愈，今‘脈浮’，故在外，當須解外則愈，宜桂枝湯。”

辨太陽病脈症并治中第五三條：“‘脈浮’者，病在表，可發汗，宜麻黃湯。”

辨太陽病脈症并治中第七三條：“太陽病，發汗後，大汗出，胃中干，煩躁不得眠，欲得飲水者，少少與飲之，令胃氣和則愈，若‘脈浮’，小便不利，微熱消渴者，五苓散主之。”

辨太陽病脈症并治中第一一八條：“傷寒‘脈浮’，醫以火迫劫之，亡陽，必驚狂，臥起不安者，桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。”

辨太陽病脈症并治中第一二一條：“‘脈浮’熱甚，而反灸之，此為實。”

辨太陽病脈症并治中第一二三條：“‘脈浮’，宜以汗解，用火灸之，邪無從出，因火而盛。”

辨太陽病脈症并治第一四七條：“太陽病，下之，其脈促，不結胸者，此為欲解也；‘脈浮’者，必結胸。”

辨太陽病脈症并治下第一六二條：“心下痞，按之濡，其‘脈关上浮’者，大黃黃連瀉心湯主之。”

辨太陽病脈症并治下第一七八條：“傷寒‘脈浮’發熱無汗，其表不解者，不可與白虎湯。”

辨陽明病脈症并治第二一〇条：“陽明病，脈浮而緊者，必潮熱，發作有時，但‘浮’者必盜汗出。”

辨陽明病脈症并治第二三〇条：“陽明病……若‘脈浮’發熱，渴欲飲水，小便不利者，猪苓湯主之。”

辨陽明病脈症并治第二三四条：“‘脈浮’發熱，口干鼻燥，能食者則衄。”

辨陽明病脈症并治第二三八条：“陽明病……病過十日‘脈續浮’者，与小柴胡湯，‘脈但浮’，无余症者，与麻黃湯。”

辨陽明病脈症并治第二四一条：“陽明病‘脈浮’，无汗而喘者，發汗則愈，宜麻黃湯。”

辨太陽病脈症并治第三八〇条：“太陽病，‘脈浮’者，可發汗，宜桂枝湯。”

辨陰陽易差后勞復病脈症并治第三九九条：“傷寒差以后，更發熱者，小柴胡湯主之，‘脈浮’者，以汗解之。”（以上傷寒論）

臟腑經絡先后病脈症第九条：“師曰：病人‘脈浮’者在前，其病在表，‘浮者’在后，其病在里，腰痛背強不能行，必短氣而極也。”

臟腑經絡先后病脈症第一二条：“五邪中人，各有法度，風中于前，寒中于暮，濕傷于下，霧傷于上，風令‘脈浮’，寒令脈急。”

瘧濕喝病脈症第三八条：“風濕‘脈浮’身重，汗出惡風者，防己黃耆湯主之。”

血痹虛勞病脈症并治第八三条：“男子面色薄者，主渴及亡血，卒喘悸，‘脈浮’者，里虛也。”

肺痿肺癰咳嗽上氣病脈症治第一〇六条：“欬而‘脈浮者’厚朴麻黃湯主之。”

肺痿肺癰咳嗽上氣病脈症治第一一二条：“肺脹，咳而上氣，煩躁而喘，‘脈浮’者，心下有水，小青龍加石膏湯主之。”

五藏風寒積聚病脈症第一六〇条：“心中寒者，其人苦病心如噉蒜狀，劇者心痛徹背，背痛徹心，譬如蠱注，其‘脈浮’者，自吐乃愈。”

消渴小便利淋病脈症并治第二一七条：“‘脈浮’，小便不利，微熱消渴者，宜利小便發汗，五苓散主之。”

消渴小便利淋病脈症并治第二二六条：“‘脈浮’發熱，渴欲飲水，小便不利者，猪苓湯主之。”

水气病脈症第二二七条：“風水，其‘脈自浮’，外症骨節疼痛，惡風，皮水其‘脈亦浮’，外症胎腫，按之沒指，不惡風，其腹如鼓，不渴，當發其汗。”

水气病脈症并治第二四八条：“風水‘脈浮’身重，汗出惡風者，防己黃芪湯主之，腹痛者加芍藥。”

水气病脈症并治第二四九条：“風水惡風，一身悉腫，‘脈浮’不渴，續自汗出，无大熱，越婢湯主之。”

水气病脈症并治第二五二条：“水之为病，其脈沉小，屬少陰。‘浮’者为風。”

黃疸病脈症并治第二六〇条：“尺‘脈浮’，为伤腎。”

黃疸病脈症并治第二六三条：“酒黃疸者，或无熱，靖言了了，腹滿，欲吐，鼻燥，其‘脈浮’先吐之，沉弦者先下之。”

黃疸病脈症并治第二七四条：“諸家病黃，但利其小便，假令‘脈浮’，当以汗解之，宜桂枝加黃芪湯主之。”

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈症并治第二八二条：“師曰：尺‘脈浮’，目睛暈黃，衄未止，暈黃去，目睛慧了，知衄令止。”（以上金匱要略）

浮脈是血管擴張，而血液充盈的現象，据張仲景的經驗，浮脈于臨床上的应用有三途：（一）体工对疾病抵抗力的亢奋：如“脈浮汗出”，“風令脈浮”，“脈浮病在表”，“欬而脈浮”，“浮者为風”，以及桂枝湯，麻黃湯等症的浮脈，都屬於这一类。都是象征着自然療能驅除病变的努力，这种抗力強的，汗出而病去，抗力不夠的，还有待借助于桂枝湯和麻黃湯等。（二）病毒亢盛的現象，如“脈浮熱甚”，“脈浮發熱”，“風濕脈浮身重”，“脈浮者，心下有水气”等都是这一类，都象征着疾病机勢的前進。（三）体温外脫的先兆：如“男子面色薄者，主渴及亡血，卒喘悸，脈浮者，里虛也。”这种浮脈，病者本來就是个劳瘵質的人，已經到了心臟極度衰弱的階段，脈管收縮，神經衰弱，而呈現的虛性兴奋，所以叫做里虛，不过这里要注意的有兩件事：（一）浮脈的性質本与大脈、洪脈差不多，其不同

的，浮脈是由于脈管的充血，洪大脈是由于心机亢盛而充血，因此，浮脈的搏动必軟于洪，而不必如其大数。(二)抵抗力強，病机亢盛，虛性兴奋，同样的能見到浮脈，这就絕對要和症狀配合起來診斷，于臨床上才中用。还有肥人皮下的組織丰隆，縱然体工亢奋，亦不見浮脈，有些瘦子生來的脈搏就很細弱，無論体工亢奋和病机亢盛，都不能見到浮脈，所以單是憑脈論症，是極度危險的事。

(19) 浮 緊 脈

辨太陽病脈症并治上第一八条：“桂枝本为解肌，若其人‘脈浮緊’發熱汗不出者，不可与之也。”

辨太陽病脈症并治中第四〇条：“太陽中風，‘脈浮緊’，發熱惡寒，身疼痛，不汗出而煩躁者，大青龍湯主之。”

辨太陽病脈症并治中第四八条：“太陽病，‘脈浮緊’无汗，發熱，身疼痛，八九日不解，表症仍在，此当發其汗。”

辨太陽病脈症并治中第四九条：“太陽病，‘脈浮緊’，發熱身无汗，自衄者愈。”

辨太陽病脈症并治中第五二条：“‘脈浮緊’者，法当身疼痛，宜以汗解之。”

辨太陽病脈症并治中第五七条：“伤寒‘脈浮緊’，不發汗，因致衄者，麻黃湯主之。”

辨太陽病脈症并治中第一一四条：“伤寒腹滿譫語，寸口‘脈浮而緊’，此肝乘脾也，名曰縱，刺期門。”

辨太陽病脈症并治中第一五九条：“‘脈浮而緊’，而復下之，緊反入里，則作痞，按之自濡，但氣痞耳。”

辨太陽病脈症并治第一九八条：“陽明中風，口苦咽干，腹滿微喘，發熱惡寒，‘脈浮而緊’若下之，則腹滿小便難也。”

辨陽明病脈症并治第二一〇条：“陽明病，‘脈浮而緊’者，必潮熱發作有時，但浮者，必盜汗出。”

辨陽明病脈症并治第二三〇条：“陽明病‘脈浮而緊’咽燥口苦，腹滿而喘，發熱汗出，不惡寒，反惡熱，身重。”(以上伤寒論)

中風歷節病脈症并治第六五条：“寸口‘脈浮而緊’緊則為寒，

浮則為虛，寒虛相搏，邪在皮膚。”

水氣病脈症并治第二三〇條：“太陽病‘脈浮而緊’，法當骨節疼痛，反不疼，身體反重而酸，其人不渴，汗出即愈，此為風水，惡寒者，此為極虛，發汗得之。”（以上金匱要略）

排血量雖充盈，而脈管纖維已萎縮呈硬化的緊張現象，便見脈浮緊，脈管纖維既萎縮，必缺乏伸展性，觸覺上但覺繃急。據張仲景的經驗，凡浮緊脈，大半都無汗，因此治療上當從汗解，假如不幫助其放汗，那末，淺層動脈愈緊張，內部的血管肌肉愈弛緩，血液越發不能達到外表，汗愈是放不出來，如“桂枝本為解肌，若其人脈浮緊，發熱汗不出者，不可與之也，當須識此，勿令誤也。”這是因為桂枝的力量小了，不能幫助其放汗，勢必要用麻黃類的藥品，才能濟事。未得到適當的幫助放汗，因而高熱致衄，這正是體工在无可奈何，找出一條散溫的道路來，因衄血而體溫低降，所以“自衄者愈”。“緊為寒，浮為虛”，是古人“表虛感寒”的演繹，即是體力失調而遭到感冒的意思，並不是指真正的虛弱言。

(20) 浮 緩 脈

辨太陽病脈症并治中第四一條：“傷寒‘脈浮緩’，身不疼，但重，乍有輕時，無少陰症者，大青龍湯發之。”

辨陽明病脈症并治第一九六條：“傷寒‘脈浮而緩’，手足自溫者，是為系在太陰。”

辨太陰病脈症并治第二八二條：“傷寒‘脈浮而緩’，手足自溫者，系在太陰。”（以上傷寒論）

黃疸病脈症并治第二五九條：“寸口‘脈浮而緩’，浮則為風，緩則為痹，痹非中風，四肢苦煩，脾色必黃，瘀熱以行。”（以上金匱要略）

浮緩脈是浮脈的較輕者，應該是沒有很重篤的病变，所以“乍有輕時”，這時體溫也不很高了，“手足自溫”，並沒有發熱的現象，在臨床上事實也是如此，“緩為痹”等說，是經脈家言，大青龍湯亦處理得不很適當。

(21) 浮 数 脈

辨太陽病脈症并治中第五一条：“‘脈浮数’者，法当汗出而愈。”

辨太陽病脈症并治中第五四条：“‘脈浮而数’者，可發汗，宜麻黃湯。”

辨太陽病脈症并治中第七四条：“發汗已，‘脈浮数’煩渴者，五苓散主之。”

辨陽明病脈症并治第二六三条：“病人无表里証，發熱七八日，虽‘脈浮数者’，可下之。”

辨厥陰病脈証并治第三六八条：“下利，寸脈反‘浮数’，尺中自濇者，必清膿血。”（以上伤寒論）

腹滿寒疝宿食病脈症治第一三五条：“病腹滿，發熱十日，‘脈浮而数’，飲食如故，厚朴七物湯主之。”

消渴小便利淋病脈症并治第二一五条：“趺陽‘脈浮而数’浮即為氣，数即消穀而大堅，氣盛則洩数，洩数即堅，堅数相搏，即為消渴。”

水氣病脈症并治第二三四条：“趺陽‘脈浮而数’，浮脈即熱，数脈即止，熱数相搏，名曰伏。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三二九条：“下利寸‘脈反浮数’尺中自濇者，必清膿血。”

瘡癰腸癰浸淫病脈症并治第三四五条：“諸‘脈浮数’，应当發熱，而反洒淅惡寒，若有痛處，當發為癰。”（以上金匱要略）

浮数脈，為交感神經所含的加動纖維，刺激心動加快，血管充盈，收縮力增強的現象，而為病機向外的熱型徵兆，張仲景以上所經驗的各條皆是。

(22) 浮 弱 脈

辨太陽病脈症并治上第一三条：“太陽中風‘陽浮而陰弱’，陽浮者熱自發，陰弱者汗自出，濇濇惡寒，淅淅惡風，翕翕發熱，鼻鳴干嘔者，桂枝湯主之。”

辨太陽病脈症并治上第四四条：“太陽病，外証未解，‘脈浮弱者’，當以汗解，宜桂枝湯。”（以上傷寒論）

中風歷節病脈症并治第七三条：“少陰‘脈浮而弱’，弱則血不足，浮則為風，風血相搏，即疼痛如掣。”

黃疸病脈症并治第二六五条：“酒疸下之，久久為黑疸，目青面黑，心中如噉蒜齏狀，大便正黑，皮膚爪之不仁，其‘脈浮弱’，雖黑微黃，故知之。”

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈症并治第二八五条：“病人面無血色，無寒熱，脈沉弦者衄，‘浮弱’，手按之絕者，下血，煩欬者必吐血。”（以上金匱要略）

淺層動脈充血，觸覺上固見浮脈，但以動脈神經弛緩之故，重按之即覺其緩弱而不緊張，這便是浮弱脈的道理。若腦溢血、黃疸病人的浮弱脈，不僅神經弛緩，血液實質則極度減少，這與桂枝湯症大不相同。

(23) 浮 細 脈

辨太陽病脈症并治中第三九条：“太陽病十日以去，‘脈浮細’，而嗜臥者，外已解也，設胸滿脅痛者，與小柴胡湯，脈但浮者，與麻黃湯。”

病機能不復亢奮，體力稍呈衰弱現象，因此脈搏浮細而嗜臥，這是疾病良好轉歸後的必然現象。

(24) 浮 大 脈

辨太陽病脈症并治上第三二条：“問曰：証象陽旦，按法治之而增劇，厥逆咽中干，兩脛拘急而譫語，師曰：言夜半手足當溫，兩腳當伸，後如師言，何以知此？答曰：寸口‘脈浮而大’，浮為風，大為虛，風則生微熱，虛則兩脛攣，病形象桂枝，因加附子參其間。”

辨太陽病脈症并治下第一三九条：“結胸症，其‘脈浮大’者，不可下，下之則死。”

辨少陰病脈症并治第二七二条：“三陽合病‘脈浮大’，上关上，但欲眠睡，目合則汗。”（以上傷寒論）

瘧疾病脈症并治第五九条：“師曰：瘧脈自弦……‘浮大’者，可吐之。”

血痹虛癆病脈症并治第八五条：“勞之為病，其‘脈浮大’，手足煩，春夏劇，秋冬瘥，陰寒精自出，酸削不能行。”

肺痿肺癰咳嗽上氣病脈症并治第一〇一条：“上氣，面浮腫，肩息，其‘脈浮大’，不治，又加利，尤甚。”

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈症并治第一一条：“欬而上氣，此為肺脹，其人喘，目如脫狀，‘脈浮大’者，越婢加半夏湯主之。”

腹滿寒疝宿食病脈症治第一四六条：“問曰：人病有宿食，何以知之？師曰：寸口‘脈浮而大’，按之反澀，尺中亦微而澀，故知有宿食，大承氣湯主之。”（以上金匱要略）

浮大，當為大脈之一種，因于心機亢盛，動脈擴大所致。陽旦病、結胸症、三陽合病、瘧疾的脈浮大，都為急性熱病進行期中的脈搏，都是病機亢奮的現象，所以見譫語、結胸（胃炎）、合目則汗、瘧、肺脹，這些熱性症狀（不過陽旦症的敘述是不通的）至于上氣喘息的脈浮大，多半是心室代償性肥大的原故，是急性支氣管炎、肺氣腫的習見症。勞之為病，其脈浮大，與前面脈大為勞是一個道理。

(25) 浮 滑 脈

辨太陽病脈症并治下第一四五条：“小結胸病，正在心下，按之則痛‘脈浮滑’者，小陷胸湯主之。”

辨太陽病脈症并治下第一四七条：“太陽病下之……‘脈浮滑者’，必下血。”

辨太陽病脈症并治下第一八四条：“傷寒‘脈浮滑’此以表有熱，里有寒，白虎湯主之。”（以上傷寒論）

中風歷節病脈症并治第七二条：“趺陽‘脈浮而滑’滑則穀氣實，浮則汗自出。”（以上金匱要略）

脈管擴張，而血液充實流利，便見浮滑脈，多見于患熱病而心力亢奮的時期。

參 閱 室

(26) 浮 迟 脉

辨陽明病脈症并治第二三二条：“‘脈浮而迟’，表热里寒，下利清穀者，四逆湯主之。”（以上伤寒論）

消渴小便不利淋病脈症并治第二一四条：“寸口‘浮脈而迟’，浮即為虛，迟即為勞，虛則衛氣不足，勞則榮氣竭。”

水氣病脈症并治第二三四条：“寸口‘脈浮而迟’，浮脈則熱，迟脈則潛，熱潛相搏，名曰沉。”（以上金匱要略）

浮迟脈等于迟浮弱脈，由于心力不足而虛性兴奋的脈搏，所以称为表热里寒（假热象）称为衛氣不足榮氣竭。

(27) 浮 虛 脉

辨陽明病脈症并治第二四六条：“病人煩熱，汗出不解，又如瘧狀，日晡所發熱者屬陽明也，脈實者宜下之，‘脈浮虛者’宜發汗。下之宜大承氣湯，發汗宜桂枝湯。”（伤寒論）

浮虛脈，即浮脈之一种，本是浮脈，不过脈管是寬軟的，便帶一种“虛”象罢了，并不是虧損的虛弱脈。

(28) 浮 芤 脉

辨陽明病脈症并治第二五二条：“‘脈浮而芤’，浮為陽，芤為陰，浮芤相搏，胃氣生熱，其陽則絕。”（伤寒論）

芤為失血過甚，心臟排血量極度弱小的一种反应脈搏，因組織失掉營養，盡量擴張血管求血，企圖得到多量的血液分布于各小血管以營養組織，但血管雖然盡量擴張，而因血已大量消失之故，終究不能充滿脈管，这时診察脈搏，便會得到芤象，正因其脈管過分擴張，故于芤之中見浮，这种脈搏，象征着心机衰弱，血壓低落，多屬危候，是以“其陽則絕。”

(29) 浮 濇 脉

辨陽明病脈症并治第二五三条：“趺陽‘脈浮而濇’，浮則胃氣強，濇則小便數，浮濇相搏，大便則鞭，其脾為約，麻子仁丸主之。”

(伤寒論)

五藏風寒積聚病脈症并治第一六六条：“趺陽‘脈浮而濇’，浮則胃氣強，濇則小便數，浮濇相搏，大便則堅，其脾為約，麻子仁丸主之。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三〇二条：“趺陽‘脈浮而濇’，浮則為虛，濇則傷脾，脾傷則不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，宿穀不化，名曰反胃。”(以上金匱要略)

脈管弛緩而寬軟，血液復枯減，神經失養，血流濡滯，便見浮濇脈，脾約兩條，脈証相參，當為身體衰弱者的習慣性便秘，反胃條疑是衰弱者的胃炎病。

(30) 浮 洪 脈

水氣病脈症并治第二二八条：“‘脈浮而洪’，浮則為風，洪則為氣，風氣相搏，風強則為隱疹，身體為痒，痒為泄風，久為痂癩；氣強則為水，難以俛仰，風氣相击，身體洪腫，汗出乃愈。”(金匱要略)

浮洪脈，當同于浮大，而病機的亢奮最甚，隱疹紅腫等，都為熱性病中所常見，風氣云云，理難說通。

(31) 浮 動 數 脈

辨太陽病脈症并治下第一四一条：“太陽病‘脈浮而動數’，浮則為風，數則為熱，動則為痛，數則為虛，頭痛發熱，微盜汗出，而反惡寒者，表未解也。”(伤寒論)

浮數脈而兼見重複脈，便是浮動數脈，其病理與浮數同，不過其神經系尤為興奮，脈管愈顯得緊張而已！其風、熱、痛云云，一律視為古人对神經症狀的概念的描寫，于理略可通，否則頗不合邏輯。

(32) 浮 虛 濇 脈

辨太陽病脈症并治下第一八二条：“伤寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔不渴，‘脈浮虛而濇’者，桂枝附子湯主之。”(伤寒論)

脈管虽擴張，而心臟排血量頗弱小，故脈搏浮中而見虛瀾，这是体力衰弱的象征，風濕病由于汗腺排洩机能的阻滯，亦或可見这种脈象。

(33) 浮 弱 瀾 脈

血痹虛勞病脈症并治第八六条：“男子‘脈浮弱而瀾’，为无子，精气清冷。”（金匱要略）

脈浮弱而瀾，是肌肉薄血管淺露（浮），而血液不足心机衰弱也。这殆为衰弱者的授胎不能症。

(34) 浮 微 瀾 脈

瘡癰腸癰浸淫病脈症并治第三四九条：“問曰：寸口‘脈浮微而瀾’，法当亡血若汗出，設不汗者云何？答曰：若身有瘡，被刀斧所伤，亡血故也。”（金匱要略）

浮微瀾脈与浮弱瀾脈同屬一理，故云“法当亡血”。

(35) 浮 細 滑 脈

痰飲咳嗽病脈症并治第一九〇条：“‘脈浮而細滑’，伤飲。”（金匱要略）

浮細滑，即浮滑脈之次者，或者脈本为浮滑，因其人脈管細小之故，不能憑脈遽指其为伤飲，这非仲景家言。

第九講 張仲景脈法（下）

（36）細 脈

辨太陽病脈症并治下第一五六条：“伤寒五六日，头汗出、微惡寒、手足冷、心下滿、口不欲食、大便難，‘脈細’者，此为陽微結，必有表復有里也。”

辨厥陰病脈症并治第三五五条：“手足厥寒‘脈細’欲絕者，当归四逆湯主之。”（以上伤寒論）

五藏風寒積聚病脈症并治第一七一条：“諸積大法，‘脈來細’而附骨者，乃積也。”（金匱要略）

凡神經衰疲，血压低降，末梢動脈管收縮者，其脈必細，正因其血压低降，所以手足厥冷。細而附骨，是細小之極的形容。

（37）細 數 脈

辨太陽病脈症并治中第一二七条：“太陽病当惡寒發熱，今自汗出，反不惡寒發熱，关上‘脈細數’者，以医吐之过也。”

辨太陽病脈症并治下第一四七条：“太陽病，下之……‘脈細數’者，头痛未止。”（以上伤寒論）

体力已衰憊，而病机犹亢奋未已，是以脈搏于細中見數，一者因吐而引起胃机能的兴奋，一者于下后而头部犹充血，都是这个原理。

（38）細 沉 數 脈

辨少陰病脈症并治第二八九条：“少陰病‘脈細沉數’病为在里，不可發汗。”（伤寒論）

細沉數脈，即細數脈，所謂細沉，犹金匱五藏風寒積聚第一七一条所謂“脈來細而附骨”者。

(39) 沉 脈

辨太陽病脈症并治中第九六条：“病發熱頭痛‘脈反沉’，若不差，身體疼痛，當救其里，宜四逆湯。”

辨陽明病脈症并治第二二七条：“傷寒五六日，‘脈沉’而喘滿，‘沉’為在里，而反發其汗，津液越出，大便為難，表虛里實，久則譫語。”

辨少陰病脈症并治第三〇五条：“少陰病，始得之，及發熱‘脈沉’者，麻黃附子細辛湯主之。”

辨少陰病脈症并治第三〇九条：“少陰病，身體疼，手足寒，骨節痛，‘脈沉’者附子湯主之。”

辨少陰病脈症并治第三二七条：“少陰病‘脈沉’者，急溫之，宜四逆湯。”（以上傷寒論）

肺痿肺癰咳嗽上氣病脈症治第一〇七条：“‘脈沉’者，澤瀉湯主之。”

痰飲咳嗽病脈症并治第一八一条：“胸中有留飲，其人短氣而渴，四肢歷節痛，‘脈沉’者，有留飲。”

水氣病脈症并治第二二七条：“石水其‘脈自沉’，外症腹滿不喘。”

水氣病脈症并治第二三一条：“里水者，一身面目黃腫，其脈‘沉’，小便不利，故令病水。”

水氣病脈症并治第二三七条：“脈得諸‘沉’，當責有水，身體腫重，水病脈出者死。”

水氣病脈症并治第二三八条：“夫水病人，目下有臥蚕，面目鮮澤，脈伏，其人消渴，病水腹大，小便不利，其‘脈沉’絕者，有水，可下之。”

水氣病脈症并治第二五四条：“問曰：黃汗之為病，身體重，發熱汗出而渴，狀如風水，汗沾衣，色正黃如蘗汁，‘脈自沉’，何從得之。”

黃疸病脈症并治第二六七条：“‘脈沉’，渴欲飲水，小便不利者，皆發黃。”（以上金匱要略）

血压低降，末梢动脉血液减少，即浅层动脉的贫血，于桡骨动脉便诊得沉脉，一般为体力衰惫的象征，所以伤寒论的沉脉，都用四逆汤、麻黄附子细辛汤、附子汤这类兴奋强壮药。水肿病的脉沉，于体力衰竭固然亦有关系，然因其肌肉浮肿，末梢动脉被压迫下着，当然得见沉脉。

(40) 沉 紧 脉

辨太阳病脉症并治中第六九条：“伤寒若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，‘脉沉紧’，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白朮甘草汤主之。”

辨太阳病脉症并治下第一四二条：“伤寒六七日结胸热实，‘脉沉而紧’，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之。”

辨太阳病脉症并治第一四七条：“太阳病，下之……‘脉沉紧’者，必欲呕。”

辨太阳病脉症并治下第一五六条：“伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便鞭……‘脉虽沉紧’，不得为少阴病。”

辨阳明病脉症并治第二七一条：“本太阳病不解，转入少阳者，脅下鞭满，干呕，不能食，往来寒热，尚未吐下，‘脉沉紧’者，与小柴胡汤。”（以上伤寒论）

痰饮咳嗽病脉症并治第一九五条：“膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其‘脉沉紧’，得之数十日，医吐下之不愈，木防己汤主之。”

水气病脉症并治第二四七条：“问曰：病者苦水，面目身体四肢皆肿，小便不利，脉之，不言水，反言胸中痛，气上冲咽，状如炙肉，当微咳喘，審如师言，其脉何类？师曰：寸口‘脉沉而紧’，沉为水，紧为寒，沉紧相搏，结在关元。”（以上金匱要略）

脉管纖維萎縮而排血量亦复不足，脈搏所見，便为沉紧，伤寒论所述，頗类似胃炎一类症候，金匱所述，前条类似慢性肋膜炎，后条指腹底骨盆腔内有积水，是沉紧脉都見于水中毒一类症候，或为收縮神經被刺激的反应使然。

(41) 沉 迟 脉

辨太陽病脈症并治中第六四条：“發汗后，身疼痛，‘脈沉迟’者，桂枝加芍藥生姜各一兩人參三兩新加湯主之。”

辨厥陰病脈症并治第三六一条：“伤寒六七日，大下后，寸‘脈沉而迟’，手足厥逆，下部脈不至，喉咽不利，唾膿血，泄利不止者，为难治，麻黃升麻湯主之。”

辨厥陰病脈症并治第三七一条：“下利‘脈沉而迟’其人面少赤，身有微热，下利清穀者，必郁冒汗出而解，病人必微厥，所以然者，其面戴陽，下虛故也。”（以上伤寒論）

水气病脈症并治第二二七条：“正水，其‘脈沉迟’，外証自喘。”

水气病脈症并治第二四六条：“师曰：寸口‘脈沉而迟’，沉則为水，迟則为寒，寒水相搏，趺陽脈伏，水穀不化，脾气衰則驚悸，胃气衰則身腫。”

嘔吐下利病脈症并治第三三一条：“下利‘脈沉而迟’，其人面少赤，身有微热，下利清穀者，必郁冒汗出而解，病人必微厥，所以然者，其面戴陽，下虛故也。”

心动弛緩，排血量減少，同时脈管收縮，脈搏即見沉迟。右列沉迟脈，或于汗后，或于下后，均为津液大伤，心机衰弱，血液減少的原故。水腫病的脈沉迟，与上列沉脈、沉緊脈同屬一理。

(42) 沉 微 脉

辨太陽病脈症并治中第六三条：“下之后，复發汗，晝日煩燥不得眠，夜而安靜，不嘔不渴，无表証，‘脈沉微’身无大热者，干姜附子湯主之。”（伤寒論）

痰飲咳嗽病脈症并治第二〇七条：“青龍湯下已，多唾口燥，寸脈‘沉’，尺脈‘微’，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足痹，其面翕热如醉狀，因复下流陰股，小便难，时复冒。”（金匱要略）

左心室排血量弱小，因而脈躍不足，則見沉微，所以身无大热，手足厥逆，所以要用于姜附子的強壯剂。

(43) 沉 結 脈

辨太陽病脈症并治中第一三二条：“太陽病，身黃，‘脈沉結’，少腹鞭，小便不利者，为无血也，小便自利，其人如狂者，血証譫也，抵当湯主之。”

不僅脈躍不足，而且瓣膜閉鎖不全，血行时有止息，便为沉結脈，这証为溶血性黄疸。

(44) 沉 滑 脈

辨太陽病脈症并治下第一四七条：“太陽病下之……‘脈沉滑’者，协热利。”（伤寒論）

水气病脈症并治第二二九条：“寸口‘脈沉滑’者，中有水气，面目腫大有热，名曰風水。”（金匱要略）

脈于沉部而得流利的脈波，是为沉滑，原因为排血量頗充实，既充实而尚以沉見者，在太陽病条，是因誤下而体力先憊，病机漸轉于亢奋，后条的沉滑，或因于橈骨部水腫的关系。

(45) 沉 弦 脈

辨厥陰病脈症并治第三七〇条：“下利‘脈沉弦’者，下重也，脈大者，为未止，脈微弱数者，为欲自止，虽發热不死。”（伤寒論）

痰飲咳嗽病脈症并治第一九二条：“‘脈沉而弦’者，懸飲內痛。”

黄疸病脈症并治第二六三条：“酒黄疸者，或无热，靖言了了，腹滿，欲吐，鼻燥，其脈浮者先吐之，‘沉弦’者，先下之。”

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈症并治第二八五条：“病人面无血色，无寒热，‘脈沉弦’者衄。”

嘔吐下利病脈症并治第三二二条：“下利‘脈沉弦’者，下重。”（以上金匱要略）

脈管于沉部仍見緊張而富彈力，便是沉弦脈，这多因于血少，不能充盈其血管，血管緊縮以維持其血压的原故。至于里急后重的下利，或为腸神經及直腹肌攣急而痛，影响于收縮神經的亢奋所

致。

(46) 沉 实 脈

辨陰陽易差后劳复病脈症并治第三九九条：“伤寒，差以后更發热者，小柴胡湯主之，脈浮者，以汗解之，‘脈沉实’者，以下解之。”（伤寒論）

沉实脈，頗同于沉滑脈，病新差脈沉中見实，这象征动脈血液已逐漸在充盈，也就可以知其所以复發热的來源。

(47) 沉 小 脈

水气病脈症并治第二五二条：“水之为病，其‘脈沉小’屬少陰。”（金匱要略）

沉小脈，略同于沉微。仍为排血量弱小的原故。

(48) 沉 大 滑 脈

藏府經脈先后病脈症并治第一条：“問曰：寸‘脈沉大而滑’，沉則为实，滑則为气，实气相搏，血气入藏即死，入腑即愈，此为卒厥。”

沉大而滑之脈，为內热亢盛之候，大与滑都是脈管的充血，以沉部見者，或为其人的素質使然。卒厥云云，經脈家的贅詞，頗难通。

(49) 沉 小 迟 脈

血痹虛劳病脈症并治第九条：“‘脈沉小迟’，名脫气，其人急行則喘喝，手足逆寒，腹滿，甚則溏泄，食不消化也。”（金匱要略）

沉小迟脈，頗同于沉迟脈，不过心藏机能尤为衰弱也。

(50) 沉 弱 脈

中風歷節病脈症并治第七条：“寸口‘脈沉而弱’，沉即主骨，弱即主筋，沉即为腎，弱即为肝，汗出入水中，如水伤心，歷節黄汗出，故曰歷節。”（金匱要略）

沉弱脈，頗同于沉微脈，這是僵麻質斯病（歷節）極度貧血的必然現象，主骨主筋之說，固為附會，而僵麻質斯的病灶，大都在筋與骨。

(51) 沉 細 脈

痿濕喝病脈症并治第一九條：“太陽病發熱，‘脈沉而細’者，名曰痿，為難治。”

痿濕喝病脈症第三〇條：“太陽病，關節疼痛而煩，‘脈沉而細’者，此名濕痹，濕痹之候，小便不利，大便反快，但當利其小便。”（以上金匱要略）

心臟衰弱的，脈搏便沉細，痿病，多為惡性腦脊髓膜炎，病而至于心臟衰弱，當然難治，濕痹多為關節炎。

(52) 沉迟小緊數脈

胸痹心痛短氣病脈症并治第一一九條：“胸痹之為病，喘息欬唾，胸背痛，短氣，寸口‘脈沉而迟’，关上‘小緊數’，栝蒌薤白白酒湯主之。”（金匱要略）

胸痹包括肋間神經痛及胃神經痛，唯其所述脈搏太複雜，而且迟數并見，這是不足取信的，按其症狀，脈搏或為沉緊。

(53) 伏 脈

痰飲咳嗽病脈症并治第一八九條：“病者‘脈伏’，其人欲自利，利反快，雖利，心下續堅滿，此為留飲欲去故也，甘遂半夏湯主之。”

水氣病脈症并治第二三二條：“趺陽‘脈當伏’今反緊，本自有寒，疝瘕腹中痛，醫反下之，下之即胸滿短氣。”

水氣病脈症并治第二三二條：“趺陽‘脈當伏’，今反數，本自有熱，清穀小便數，今反不利，此欲作水。”

水氣病脈症并治第二三八條：“夫水病人，目下有臥蚕，面色鮮澤，‘脈伏’，其人消渴。”（以上金匱要略）

脈沉至極，便為伏脈，多為腹內臟器有急劇病變，血液集中病所以為救濟，而橈骨動脈的搏動，便極微薄。還要抵抗急性重病，

心力一时衰竭，不能为济，脈亦見伏，首条的脈伏，屬於前者，水气人的脈伏，便屬於后者。

(54) 伏 弦 脈

痙湿喝病脈症并治第二四条：“暴腹脹大者，为欲解，脈如故，反‘伏弦’者，痙。”（金匱要略）

伏弦脈即过去西医的小硬脈，即是上述伏脈之第一种。

(55) 芤 动 微 紧 脈

血痹虛勞病脈症并治第八七条：“脈得諸‘芤动微紧’，男子失精，女子夢交。”（金匱要略）

芤与微，可能屬於一个脈性，都是血液減少，血压低降，神經衰憊的象征；而动与紧可能为另一同屬脈性，都是血液充沛，血压增高，脈管緊張的征候，二者万难同时并見，因前者为衰減性，后者为亢奋性，失精的虛弱人，可能見前者脈搏；夢交有屬於腦神經充血而亢奋，可能見后者脈搏。丹波元胤說：“芤与微反，动与紧反，盖芤动与微紧，自是二脈。”不知其作何解释。

(56) 弦 脈

辨太陽病脈症并治下第一四七条：“太陽病，下之……‘脈弦’者，必兩脅拘急。”

辨太陽病脈症并治下第一五〇条：“太陽与少陽併病，头項強痛，或眩冒，时如結胸，心下痞鞕者，当刺大椎第一間肺俞，慎不可發汗，發汗則譫語‘脈弦’，五日譫語不止，当刺期門。”

辨陽明病脈症并治第二二一条：“伤寒若吐若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所發潮热，不惡寒，独語如見鬼狀，若劇者，發則不識人，循衣摸床，惕而不安，微喘直視，‘脈弦’者生，濇者死，微者但發热。”（以上伤寒論）

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一三一条：“寸口‘脈弦’者，即脅下拘急而痛，其人噤噤惡寒也。”

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一四五条：“其脈數而紧乃‘弦’，

狀如弓弦，按之不移。”

五藏風寒積聚病脈症并治第一六一条：“心伤者，其人勞倦，卽头面赤而下重，心中痛而自煩發熱，當臍跳，其‘脈弦’，此為心臟傷所致也。”

痰飲咳嗽病脈症并治第一八三条：“夫病人飲水多，必暴喘滿，凡食少飲多，水停心下，甚者則悸，微者短氣，‘脈双弦’者寒也，皆大下后喜虛，‘脈偏弦’者，飲也。”

痰飲咳嗽病脈症并治第二〇三条：“欬家，其‘脈弦’，為有水，十棗湯主之。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三〇〇条：“‘脈弦’者虛也，胃氣無余，朝食暮吐，變為胃反，寒在于上，醫反下之，今‘脈反弦’，故名曰虛。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三二七条：“下利‘脈反弦’，發熱身汗者，自愈。”

婦人妊娠病脈症并治第三六二条：“婦人妊娠六七月，‘脈弦’發熱，其胎愈脹，腹痛惡寒者，少腹如扇，所以然者，子藏開故也，當以附子湯溫其藏。”（以上金匱要略）

脈管壁的收縮神經興奮，脈搏卽弦，惟其屬於神經的病变，影响所及，多為神經系統的病症，如譫語、痛、拘急，就是这个理由，弦脈的脈管虽緊張，而其血液不充盈，重按卽陷，血流的搏動顯于脈管的兩边，這叫做“双弦”，也就是其脈弦屬虛的由來。病到了發不識人的時候，謂“脈弦者生”，這是見其于血行減退之中而抵抗力犹有与病勢相爭的能力的原故。下利后的脈弦發熱身汗自愈，也就是这个道理。

(57) 弦 細 脈

辨少陽病脈症并治第二七〇条：“傷寒‘脈弦細’，頭痛發熱者，屬少陽。”（傷寒論）

弦脈的血液本不充盈，今更因排血量的弱小，便于弦中顯細，是體力不很好的征象。

(58) 弦 迟 脈

辨少陰病脈症并治第三二八条：“少陰病，飲食入口則吐，心中溫溫欲吐，復不能吐，始得之，手足寒‘脈弦迟’者，此胸中實，不可下也，當吐之。”（傷寒論）

瘧病脈症并治第五九条：“師曰：瘧脈自弦，‘弦迟’者多寒……‘弦迟’者可溫之。”（金匱要略）

動脈管收縮而心動復弛緩者，便見弦迟脈，正因其心動弛緩，排血量不充分，所以見手足寒。

(59) 弦 小 緊 脈

瘧病脈症并治第五九条：“師曰：瘧脈自弦……‘弦小緊’者，下之差。”（金匱要略）

弦與緊，同為脈管壁的收縮神經興奮所致，所以最易同見，不過緊脈要比較的血充，弦脈不會充血，小，徒見其淺層動脈收縮之極，這言其弦小已足，不必言緊，至于憑弦小緊脈，便云下之差，這是沒有根據的診斷治療，非出自仲景。

(60) 弦 緊 脈

瘧病脈症并治第五九条：“師曰：瘧脈自弦，……‘弦緊’者可發汗，鍼灸也。”

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一四二条：“腹痛‘脈弦而緊’，弦則衛氣不行，即惡寒，緊則不欲食，邪正相搏，即為寒疝。”

水氣病脈症并治第二三五条：“寸口‘脈弦而緊’，弦則衛氣不行，即惡寒，水不沾流，走于腸間。”（以上金匱要略）

弦緊脈，便是緊脈。弦緊字重複用，反覺其不可通。

(61) 弦 數 脈

瘧病脈症并治第五九条：“師曰：瘧脈自弦，‘弦數’者多熱……‘弦數’風發也，以飲食消息止之。”

痰飲咳嗽病脈症并治第一九一条：“‘脈弦數’，有寒飲，冬夏難

治。”(以上金匱要略)

收縮神經與交感神經同時興奮，一面淺層動脈收縮，一面心動亢進，便見弦數脈，的是病機亢奮的象徵。冬夏難治云云，不可訓。

(62) 弦浮大脈

辨陽明病脈症并治第二三七條：“陽明中風，‘脈弦浮大’而短氣，腹都滿，脅下及心痛，久按之氣不通，鼻干不得汗，嗜臥，一身及目悉黃，小便難，有潮熱，時時噦，耳前後腫。”(傷寒論)

弦浮大，略同于弦數脈，病機正亢盛也。這是急性的流行性腮腺炎病。

(63) 弦細芤迟脈

瘧濕喝病脈症并治第四一條：“太陽中喝，發熱惡寒，身重而疼痛，其‘脈弦細芤迟’，小便已，洒洒然毛聳，手足逆冷，小有勞，身即熱，口前干，板齒燥。”

淺層動脈微見收縮，津液不足，血中水分少，因而弦細而芤，繼以體溫不足，心搏動弛緩，至數亦不足而迟，所以洒洒然毛聳，手足厥冷。

(64) 緊脈

辨太陽病脈症并治上第三條：“太陽病或已發熱，或未發熱，必惡寒，體痛嘔逆，脈陰陽俱‘緊’者，名曰傷寒。”

辨太陽病脈症并治下第一四七條：“太陽病，下之……‘脈緊’者，必咽痛。”

辨陽明病脈症并治第二〇一條：“陽明病，初欲食，小便反不利，大便自調，其人骨節疼，翕翕如有熱狀，奄然發狂，濇然汗出而解者，此水不勝穀氣，與汗共并，‘脈緊’則愈。”

辨少陰病脈症并治第二八七條：“病人脈陰陽俱‘緊’，反汗出者，亡陽也，此屬少陰，法當咽痛而復吐利。”

辨少陰病脈症并治第二九一條：“少陰病，‘脈緊’至七八日自下利，脈暴微，手足反溫，‘脈緊’反去者，為欲解也。身重下利，



必自愈。”

辨厥陰病脈症并治第三五九条：“病人手足厥冷，‘脈乍緊’者，邪結在胸中，心下滿而煩，飢不能食者，病在胸中，當須吐之，宜瓜蒂散。”

辨厥陰病脈症并治第三六五条：“下利，脈數，有微熱，汗出，令自愈，設復‘緊’，為未解。”（以上傷寒論）

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一五一条：“‘脈緊’，頭痛風寒，腹中有宿食不化也。”

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一五〇条：“‘脈緊’，如轉索無常者，有宿食也。”

水氣病脈症并治第二三二条：“趺陽脈當伏，今反‘緊’，本自有寒，疝瘕腹中痛，醫反下之，下之即胸滿短氣。”

黃疸病脈症并治第二六〇条“趺陽‘脈緊’，為傷脾，風寒相搏，食穀即眩，穀氣不消，胃中苦濁。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三一六条：“吐後渴欲得水而貪飲者，文蛤湯主之，兼主微風‘脈緊’頭痛。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三二五条：“下利脈數，有微熱汗出，令自愈，設‘脈緊’，為未解。”（以上金匱要略）

緊脈與弦脈，同為脈管壁的收縮神經興奮的結果，其不同於弦脈的，緊脈的張度要比較弦脈硬而實大，這是由其淺層動脈充血的原故。如“脈陰陽俱緊者，名曰傷寒”，就是淺層動脈收縮神經，與皮膚汗腺同時收縮，血液復繼續充盈不已而見的緊張，不過就是由感冒的刺激所致，是一時性的；而“少陰病脈緊”，是由于皮下脂肪消盡，組織萎縮所致，這都是時間性的，應當增加營養，救濟體工為是，“緊反去者，為欲解也”，“設復緊為未解”，便是這個道理。一般說緊脈為有寒，是屬於前者，“宿食”雖亦現緊脈，而于外感亦有關係，一般的消化不良，往往先由感冒而起，所以說：“脈緊頭痛風寒，腹中有積食不化也。”

(65) 緊 弦 脈

痙濕喝病脈症并治第二五条：“夫痙脈，按之‘緊如弦’，直上

下行。”

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一四〇条：“脅下偏痛，發熱，其‘脈緊弦’，此寒也，以溫藥下之，宜大黃附子湯。”（以上金匱要略）

緊弦之脈，同屬一体，為緊為弦，便在充血之有無來區分。

(66) 緊 沉 脈

水氣病脈症并治第二三六条：“少陰‘脈緊而沉’，緊則為痛，沉則為水，小便即難。”（金匱要略）

理與沉緊脈同。

(67) 緊 數 脈

黃疸病脈症并治第二六〇条：“趺陽‘脈緊而數’，數則為熱，熱則消穀，緊則為寒，食即為滿。”（金匱要略）

交感神經與收縮神經同時興奮，便見緊數脈，即脈管緊張而至數亦加多，這是病機亢奮的現象。

(68) 緊 大 迟 脈

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一四五条：“‘脈緊大而迟’者，必心下堅。”（金匱要略）

脈緊大而迟，便是大緊脈，所以與大緊脈用同一治療法，其迟無非是脈至比較的稍減一至半至而已。

(69) 革 脈

血痹虛勞病脈症并治第九二条：“脈弦而大，弦則為減，大則為芤，減則為寒，芤則為虛，寒虛相搏，此名為‘革’，婦人則半產漏下，男子則亡血失精。”

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈症并治第二八八条：“寸口脈弦而大，弦則為減，大則為芤，減則為寒，芤則為虛，寒虛相搏，此名曰‘革’，婦人則半產漏下，男子則亡血。”

婦人雜病脈症并治第三九五条：“寸口脈弦而大，弦則為減，大則為芤，減則為寒，芤則為虛，寒虛相搏，此名曰‘革’，婦人則半

產漏下，旋復花湯主之。”（以上金匱要略）

革脈為營養失常，血液稀薄，神經虛性興奮，脈管硬變所致。所以上列同樣的三條，都為塞為虛，為亡血，為失精。

(70) 弱 脈

辨太陽病脈症并治中第一一九條：“形作傷寒，其脈不弦緊而‘弱’，‘弱’者必渴，被火必譫語，‘弱’者發熱，脈浮解之，當汗出愈。”

辨陽明病脈症并治第二五七條：“得病二三日，‘脈弱’，無太陽柴胡症，煩躁，心下鞕，至四五日，雖能食，以小承氣湯，少少與微和之，令小安。”

辨太陰病脈症并治第二八四條：“太陰為病，‘脈弱’，其人續自便利，設當行大黃芍藥者，宜減之，以其人胃氣弱易動故也。”

辨厥陰病脈症并治第三六四條：“下利有微熱而渴，‘脈弱’者，令自愈。”

辨厥陰病脈症并治第三八二條：“嘔而‘脈弱’，小便復利，身有微熱，見厥者，難治，四逆湯主之。”（以上傷寒論）

痰飲咳嗽病脈症并治第二〇五條：“久咳數歲，其‘脈弱’者可治。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三一一條：“嘔而‘脈弱’，小便復利，身有微熱，見厥者難治，四逆湯主之。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三二五條：“下利有微熱而渴，‘脈弱’者，令自愈。”（以上金匱要略）

心力弱而血又少，因而神經衰憊，官能減退，動脈血壓低降，便見弱脈，雖和軟脈很相似，但軟為脈管的弛緩，而弱為心力的衰弱，是其大較。弱而渴，是津液的枯竭，弱而利，是胃腸機能的衰減。久病脈弱，是官能減退的一般現象，弱令自愈，是對待病機亢進時的脈搏而言。

(71) 弱 濇 脈

辨少陰病脈症并治第二九〇條：“少陰病，脈微，不可發汗，亡

陽故也，陽已虛，尺‘脈弱濇’者，復不可下之。”

同上弱脈，不过这尤見其搏動的徐緩濡滯而然。

(72) 微 脈

辨太陽病脈症并治第二五条：“太陽病，得之八九日，如瘧狀，發熱惡寒，熱多寒少，其人不嘔，清便欲自可，一日二三度發，脈微緩者，為欲愈也。‘脈微’，而惡寒者，此陰陽俱虛，不可更發汗更下更吐也。”

辨太陽病脈症并治中第五一条：“脈浮數者，法當汗出而愈，若下之，身重心悸者，不可發汗，當自汗出乃解，所以然者，尺中‘脈微’，此里虛，須表里實，津液自和，便自汗出愈。”

辨太陽病脈症并治第九八条：“太陽病未解，脈陰陽俱‘微’，必先振慄汗出而解，但陽‘脈微’者，先汗出而解，但陰‘脈微’者，下之而解，若欲下之，宜調胃承氣湯。”

辨太陽病脈症并治中第一一条：“傷寒十三日，過經譫語者，以有熱也，當以湯下之，若小便利者，大便當硬，而反下利，脈調和者，知醫以丸藥下之，非其治也，若自下利者，脈當‘微’厥，今反和者，此為內實也，調胃承氣湯主之。”

辨太陽病脈症并治下第一六八条：“傷寒吐下後發汗，虛煩‘脈甚微’，八九日心下痞硬，脅下痛，氣上沖咽喉，眩冒，經脈動惕者，久而成瘥。”

辨陽明病脈症并治第二五一条：“脈陽‘微’，而汗出少者，為自和也。”

辨少陰病脈症并治第二九〇条：“少陰病，‘脈微’，不可發汗，亡陽故也。”

辨少陰病脈症并治第二九一条：“少陰病，脈緊，至七八日，自下利，‘脈暴微’，手足反溫，脈緊反去者，為欲解也，雖煩下利，必自愈。”

辨少陰病脈症并治第二九四条：“少陰中風，脈陽‘微’陰浮者，為欲愈。”

辨少陰病脈症并治第三一九条：“少陰病，下利，‘脈微’者，與

白通湯。”

辨少陰病脈症并治第三二一条：“少陰病，下利清穀，里寒外熱，手足厥逆，‘脈微欲絕’，身反不惡寒者，其人面色赤，或腹痛，或干嘔，或咽痛，或利止，脈不出者，通脈四逆湯主之。”

辨厥陰病脈症并治第三四二条：“伤寒‘脈微’而厥，至七八日膚冷，其人躁無暫時安者，此為藏厥，非蜃厥也。”

辨厥陰病脈症并治第三四七条：“伤寒六七日，‘脈微’，手足厥冷，煩躁，灸厥陰，厥不還者死。”

辨霍亂病脈症并治第三九〇条：“惡寒‘脈微’，而復利，利止，亡血也，四逆加人參湯主之。”

辨霍亂病脈症并治第三九五条：“既吐且利，小便復利，而大汗出，下利清穀，內寒外熱，‘脈微’欲絕者，四逆湯主之。”

辨霍亂病脈症并治第三九五条：“吐下已斷，汗出而厥，四肢拘急不解，‘脈微’欲絕者，通脈四逆加豬胆湯主之。”（以上傷寒論）

血痹虛勞病脈症并治第八一条：“血痹，陰陽俱‘微’，寸口关上‘微’，尺中小緊，外証身體不仁，如風痹狀，黃芪桂枝五物湯主之。”（金匱要略）

心弱血少，脈管又不能適量緊張，便成微脈，兼而有軟（濡）脈和弱脈的病理，是神經衰憊，動脈血壓低降的征候。如“脈微而惡寒”，“脈微里虛”，“虛煩脈微”，“下利脈微”，“脈陽微而汗出少”，“脈微不可發汗”，“脈微手足厥冷”等，都是由于心臟衰弱，血液減少，體溫低落而來的。但是与此相反的，其中偏有“脈暴微，手足反溫，脈緊反去，為欲解”的病例，這是說明先存在的緊脈，殆由于病毒刺激收縮神經而然，現在病毒消失了，收縮神經恢復了正常，而心臟在這七八日抗病期中，衰弱已極，則“緊”去“微”顯，因此主病欲解，脈虽微而手足反溫，更知其心臟在衰弱之中，已逐漸的走向健康。

(73) 微 緩 脈

辨太陽病脈症并治上第二五条：“太陽病，得之八九日，如瘧狀，發熱惡寒，熱多寒少，其人不嘔，清便欲自可，一日二三度發，

‘脈微緩’者，為欲愈也。”（傷寒論）

緩脈是調節均勻的脈搏，微中帶緩，病機已漸作良好的轉歸，故為欲愈。

(74) 微 弱 脈

辨太陽病脈症并治上第二九條：“太陽病發熱惡寒，熱多寒少，‘脈微弱’者，此無陽也，不可發汗，宜桂枝二越婢一湯。”

辨太陽病脈症并治中第四〇條：“太陽中風，脈浮緊，發熱惡寒，身疼痛，不汗出而煩躁者，大青龍湯主之，若‘脈微弱’汗出惡風者，不可服之。”

辨太陽病脈症并治下第一四六條：“太陽病二三日，不能臥，但欲起，心下必結，‘脈微弱’者，此本有寒分也。”（以上傷寒論）

溼濕喝病脈症并治第四三條：“太陽中喝，身熱疼重，而‘脈微弱’，此以夏月傷冷水，水行皮中所致也，一物瓜蒂湯主之。”

婦人產後病脈症并治第三七五條：“婦人郁冒，其‘脈微弱’，嘔不能食，大便反堅，但頭汗出，所以然者，血虛而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出。”（以上金匱要略）

中暑中熱的脈搏微弱，這是必然現象，由於心力一時性的衰竭所致。婦人得產褥熱的脈搏微弱，或因新產血虛使然，故曰“血虛而厥。”

(75) 微 數 脈

辨太陽病脈症并治中第一二二條：“‘微數’之脈，慎不可灸，因火為邪，則為煩逆。”（傷寒論）

百合狐惑陰陽毒病脈症并治第四四條：“論曰：百合病……其‘脈微數’，每溺時頭痛者，六十日乃愈。”

中風歷節病脈症并治第六四條：“夫風之為病，當半身不遂，或但臂不遂者，此為痹，‘脈微而數’，中風使然。”

肺痿肺癰咳嗽上氣病脈症并治第一〇〇條：“問曰：病欬逆，脈之，何以知此為肺癰，當有膿血，吐之則死，其脈何類？師曰：寸口‘脈微而數’，微則為風，數則為熱，微則汗出，數則惡寒。”

嘔吐瀉下利病脈症并治第三〇一条：“寸口‘脈微而數’，微則无气，无气則榮虛，榮虛則血不足，血不足則胸中冷。”（以上金匱要略）

心力不足，血液減少，而動脈神經反呈虛性興奮，則見微數脈，因此不可用灸，再刺激其興奮，而衰竭其心臟，若患神經衰弱（百合病）的人，心力已弱，而神經又易于興奮，其脈亦微弱。中風人的脈微弱，心力早衰，血管又硬變的原故。染肺病的脈微數，也是由于營養不良的虛性興奮。患胃病的人脈微數，亦是營養障礙的特征，所以說：“无气則營虛，營虛則血不足。”

(76) 微 沉 脈

辨太陽病脈症并治中第一三一条：“太陽病，六七日，表証仍在，‘脈微而沉’，反不結胸，其人發狂者，以熱在下焦，少腹當鞕滿，小便自利者，下血乃愈。”（傷寒論）

微沉之脈，為脈躍不足，因而脈搏的起落不很明顯，胃炎病的脈沉微，多為水中毒之故，其心臟仍然是很衰憊的，所以發狂而脈微沉。

(77) 微 濇 脈

辨陽明病脈症并治第二二三條：“陽明病，譫語發潮熱，脈滑而疾者，小承氣湯主之，因與承氣湯一升，腹中轉失氣者，更服一升，若不轉失氣者，勿更與之，明日又不大便，‘脈反微濇’者，里虛也，為難治，不可更與承氣湯也。”

辨少陰病脈症并治第三二九條：“少陰病，下利‘脈微濇’，嘔而汗出，必數更衣，反少者，當溫其上，灸之。”

辨霍亂病脈症并治第三八九條：“傷寒，其‘脈微濇者’，本是霍亂。”（以上傷寒論）

血痹虛勞病脈症并治第八〇條：“問曰：血痹病，從何得之？師曰：夫尊榮人，骨弱，肌膚盛，重因疲勞，汗出，臥不得動搖，加被微風，遂得之，但以‘脈自微濇’，在寸口关上小緊，宜鍼引陽氣，令脈和緊去則愈。”

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一四六条：“問曰：人病有宿食，何以知之？師曰，寸口脈浮而大，按之反濇，尺中亦‘微而濇’，故知有宿食，大承氣湯主之。”（以上金匱要略）

微濇脈，亦同于微弱脈，心臟弱，血液少的原故，所以“主里虛”，“宜鍼引陽氣”，霍亂與下利的脈微濇，同為体液消失過多之候。

(78) 微 細 脈

辨太陽病脈症并治中第六二条：“下之后，復發汗，必振寒，‘脈微細’，所以然者，以內外俱虛故也。”

辨少陰病脈症并治第二八五条：“少陰之為病，‘脈微細’，但欲寐也。”（以上傷寒論）

少陰病為全身機能衰減的病証，脈搏微細，是其心臟衰弱之一端，但欲寐，又是腦神經的貧血。

(79) 微 浮 脈

辨太陽病脈症并治下第一七四条：“病如桂枝証，頭不痛，項不強，寸‘脈微浮’，胸中痞硬，氣上沖咽喉，不得息者，此為胸有寒也，當吐之，宜瓜蒂散。”

辨少陰病脈症并治第二九四条：“少陰中風，‘脈陽微陰浮’者，為欲愈。”

辨厥陰病脈症并治第三三一条：“厥陰中風，‘脈微浮’為欲愈，不浮為未愈。”（以上傷寒論）

微浮脈，是心臟已由衰竭而逐漸的轉向正常，所以于微弱之中而略帶浮象，這証明心臟的唧筒作用在開始恢復，能夠漸次的起正常排血作用，是以浮為欲愈，不浮為未愈。微中帶浮，亦象征着病機的向上迫，兼以有“氣沖咽喉不得息”的証候，便就其勢而吐之。

(80) 微 實 脈

婦人產後病脈症并治第三八〇条：“產後七八日，無太陽証，少腹堅痛，此惡露不尽，不大便，煩躁發熱，切‘脈微實’，再倍發熱，

日晡时烦躁者，不食，食则讞語。”(金匱要略)

產后因失血，脈固微，但其心藏素強，又因其正在發熱，所以微而帶實。

(81) 微 弦 脈

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一二七条：“趺陽脈‘微弦’，法當腹滿，不滿者必便難，兩脇疼痛，此虛寒從下上也，當以溫藥服之。”

趺蹠手指臂腫轉筋陰狐疝蚘虫病脈症并治第三五五条：“轉筋之為病，其人臂脚直，脈上下行，‘微弦’。轉筋入腹者，雞屎白散主之。”(以上金匱要略)

排血量弱，動脈神經失濡養而緊張，脈見微弦，急性腹膜炎，固常見這樣的脈搏，如前條便是，轉筋而脈微弦，是脈管神經同時痙攣的原故。

(82) 微 迟 脈

水氣病脈症并治第二五六条：“趺陽‘脈微而迟’，微則為氣，迟則為寒，寒氣不足，則手足逆冷。”(金匱要略)

心動弛緩，血液不足，脈見微迟，必然血壓下降，體溫低落，所以“手足逆冷。”

(83) 微 大 迟 脈

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈症并治第二九〇条：“病人胸滿唇痿，舌青口燥，但欲嗽水，不欲嚥，無寒熱，‘脈微大來迟’，腹不滿，其人言我滿，為有瘀血。”(金匱要略)

脈微大來迟，是心藏大作張縮，欲沖去血管中的栓塞，張縮大則力不繼，因此濟之以迟。

(84) 微 弱 數 脈

辨厥陰病脈症并治第三七〇条：“下利，脈沉弦者，下重也，脈大者，為未止，‘脈微弱數’者，為欲自止，雖發熱不死。”(傷寒論)

嘔吐下利病脈症并治第三二二条：“下利……‘脈微弱數’

者，为欲自止，虽發熱不死。”（金匱要略）

微弱數脈，頗同于微數脈，或微浮脈，須憑症判斷。

(85) 微細沉脈

辨少陰病脈症并治第三〇四條：“少陰病，‘脈微細沉’，但欲臥，汗出不煩，自欲吐，至五六日自利，復煩躁不得臥寐者死。”

微細沉脈，略同于微沉脈，是心弱血少的征候。

(86) 微濇長脈

辨太陰病脈症并治第二七八條：“太陽中風，四肢煩疼，‘陽微陰濇而長’者，为欲愈。”（傷寒論）

脈搏于微濇中見長象，是其虽为心弱血少，但其動脈神經已逐漸條達，血流已逐漸暢和，征兆其官能逐漸充進，而有向愈的機轉。

(87) 虛脈

辨厥陰病脈症并治第三五一條：“傷寒五六日，不結胸，腹濡‘脈虛’復厥者，不可下，此为亡血，下之死。”（傷寒論）

血痹虛勞病脈症并治第八二條：“夫男子平人，脈大为勞，極‘虛’亦为勞。”

痰飲咳嗽病脈症并治第二〇五條：“久欬數歲，其脈弱者可治，失大數者死，其‘脈虛’者，必苦冒，其人本有支飲在胸中故也。治屬飲家。”（以上金匱要略）

動脈管的擴張和收縮兩種神經都不興奮，以致脈管弛緩，而且血液亦極度減少，這便構成了虛脈的條件，所以叫做亡血，所以見于勞病，見于久咳的人。

(88) 虛沉弦脈

血痹虛勞病脈症并治第八四條：“男子‘脈虛沉弦’，无寒熱，短氣里急小便難，面色白，時目瞑兼衄，少腹滿，此为勞使之然。”（金匱要略）

虛沉弦脈，略同于沉弦脈，不過其脈的本質，尤其虛弱也。

(89) 虛 芤 迟 脈

血痹虛勞病脈症并治第八七条：“夫失精家，少腹弦急，陰頭寒，目眩，髮落，脈極‘虛芤迟’，为清谷亡血失精。”（金匱要略）

这是心弱血少，已虛弱到極度的脈搏，宜其見以上的証候。

(90) 虛 弱 細 微 脈

血痹虛勞病脈症并治第八九条：“男子平人，‘脈虛弱細微’者，喜盜汗也。”（金匱要略）

这都是虛弱到了極度的脈搏，盜汗也是虛弱人極常見的症候。

(91) 实 脈

辨陽明病脈症并治第二四六条：“病人煩熱，汗出則解，又如瘧狀，日晡所發熱者，屬陽明也，‘脈实者’，宜下之。”

辨陽明病脈症并治第二五一条：“陽‘脈实’，因發其汗，出多者，亦为太過。”

辨厥陰病脈症并治第三七四条：“伤寒下利，日十余行，‘脈反实’者死。”（以上伤寒論）

動脈血液充盈，血压亢進，便見实脈，这是病机在亢進时期，而体力亦努力抵抗的現象，所以宜下宜汗，至于在下利疲憊之下，而見实脈，这是心臟的虛性兴奋，以圖“背城借一”，終究会益陷于疲憊而不可救。

(92) 实 大 数 脈

痰飲咳嗽病脈症并治第二〇五条：“久欬数歲，其脈弱者可治，‘实大数’者死。”（金匱要略）

久病的体力早已衰竭，反而見这实大数脈，必然是由于心臟的最后掙扎使然，終会不久不能为繼而不治。

(93) 滑 脈

辨厥陰病脈症并治第三五四条：“伤寒‘脈滑’而厥者，里有热

也，白虎湯主之。”(傷寒論)

嘔吐噦下利病脈症并治第三三六條：“下利‘脈反滑’者，當有所去，下乃愈，宜大承氣湯。”(金匱要略)

脈管的縮張都快，而脈波充實流利，便為滑脈，是體溫昇騰，血壓亢進的象徵。

(94) 滑 數 脈

辨陽明病脈症并治第二六二條：“陽明少陽合病，必下利……‘脈滑而數’者，有宿食也，當下之，宜大承氣湯。”(傷寒論)

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈症并治第九九條：“師曰：為肺痿之病，若口中辟辟燥，欬即胸中隱隱痛，‘脈反滑數’，此為肺癰欬唾膿血。”

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一四七條：“‘脈數而滑’者，實也，此有宿食，下之愈，宜大承氣湯。”

婦人雜病脈症并治第四〇四條：“少陰‘脈滑而數’者，陰中即生瘡，陰中蝕瘡爛者，狼牙湯洗之。”(以上金匱要略)

滑數脈，略同于數急脈，心動亢進，血流充實所致，多見于炎症蔓延，體溫上升的時期。

(95) 滑 疾 脈

辨陽明病脈症并治第二二三條：“陽明病，謔語發潮熱，‘脈滑而疾’者，小承氣湯主之。”(傷寒論)

神經緊張，心動亢進，脈管內血流過度的充盈，便見滑疾脈，常見于高熱期。

(96) 動 弱 脈

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈症并治第二八一條：“寸口‘脈動而弱’，動則為驚，弱則為悸。”(金匱要略)

神經興奮，脈管緊張，脈波降落時有小隆起而富彈力，便是動脈。多見于神經系的疾病。動而弱是由于排血量的弱小所致。

(97) 濇 脈

腹滿寒疝宿食病脈症并治第一四六条：“問曰：人病有宿食，何以知之？師曰：寸口脈浮而大，按之反‘濇’，尺中亦微而‘濇’，故知有宿食，大承氣湯主之。”

嘔吐噦下利病脈症并治第三二九条：“下利，寸脈反浮數，尺自‘濇’者，必清膿血。”（以上金匱要略）

辨太陽病脈症并治中第五〇条：“何以知汗出不徹，以‘脈濇’故知也。”

辨陽明病脈症并治第二二一条：“伤寒若吐若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所發潮熱，不惡寒，獨語如見鬼狀，若劇者，發則不識人，循衣摸床，惕而不安，微喘直視，脈弦者生，‘濇’者死。”

辨厥陰病脈症并治第三六八条：“下利，寸脈反浮數，尺中自‘濇’者，必清膿血。”（以上傷寒論）

血液枯減，神經失養，血流粘滯，甚或動脈硬化而脈管的彈力減少，便成濇脈，這是體力衰竭的象徵。“下利，寸脈反浮數，尺自濇者，必清膿血。”浮數脈才會見清膿血，脈濇是見于清膿血以後。

(98) 濇 弦 脈

辨太陽病脈症并治中第一〇五条：“伤寒，‘陽脈濇，陰脈弦’，法當腹中急痛，先与小建中湯，不差者，小柴胡湯主之。”（傷寒論）

濇而弦，是血流弱小，脈管收縮神經緊張所致，其所以弦，是由于劇痛的反应。

(99) 濇 小 脈

中風歷節病脈症并治第七四条：“盛人‘脈濇小’，短氣，自汗出，歷節疼，不可屈伸，此皆飲酒，汗出當風所致。”（金匱要略）

肥盛人的脈搏，因其肌肉特厚，常見濇小，這是體質使然，不必由于汗出飲酒當風。

(100) 急 脈

臟腑經絡先后病脈症第一三条：“寒令‘脈急’。”（金匱要略）
急即緊急，是和緊脈一個道理。

(101) 急 緊 脈

辨太陽病脈症并治中第九〇条：“衄家不可發汗，汗出必額上陷，‘脈急緊’，直視不能眴，不得眠。”（傷寒論）

血管收縮，以維持血壓，脈顯急緊狀，這常見于體液過分消失的症候。

(102) 小 脈

辨少陽病脈症并治第二七五条：“傷寒三日，少陽脈‘小’者，為欲愈也。”（傷寒論）

神經衰弱，動脈血壓低減，抵抗力薄，脈搏便顯小，在旧說，少陰脈本應見弦緊，“小者為欲已”，恐怕是指弦緊的脈象已減退的原故，不然，便不可通。

(103) 小 緊 脈

血痹虛勞病脈症并治第八〇条：“血痹病，在寸口关上‘小緊’，宜鍼引陽氣，令脈和緊去則愈。”

血痹虛勞病脈症并治第八一条：“血痹病，陰陽俱微，寸口关上微，尺中‘小緊’，外証身體不仁，如風痺狀，黃芪桂枝五物湯主之。”

淺層動脈收縮，便見小緊脈，惟其收縮之故，體溫不能隨着血液的流行充沛肌表，所以身體不仁，所以宜鍼引陽氣。

(104) 小 弱 脈

婦人妊娠病脈症并治第三六〇条：“師曰：婦人得平脈，陰脈‘小弱’，其人渴，不能食，無寒熱，名妊娠，桂枝湯主之。”（金匱要略）

小弱脈，本是體力衰憊的象徵，沒有証候的憑據，不能斷為妊娠。

仲景書中各病條下所列這些脈搏，有的固然出之仲景的精確記載，有許多是偽出于後人，尤其是關於憑脈斷症這一類病條的脈搏，十之八九都不可靠，例如：

“寸口脈遲而緩，遲則為寒，緩則為虛，營緩則為亡血，衛緩則為中風。”

“寸口脈浮而緊，緊則為寒，浮則為虛，寒虛相搏，邪在皮膚。”

“寸口脈浮而緩，浮則為風，緩則為痹，痹非中風，四肢苦煩。”

“趺陽脈浮而數，浮脈即熱，數脈即止，熱止相搏，名曰伏。”

“趺陽脈浮而瀉，浮則為虛，瀉則傷脾。”

“脈浮而洪，浮則為風，洪則為氣。”

像這一類的以脈斷症，起碼是王叔和之流所附益的，殊無取法價值。陸淵雷金匱今釋說：“惟叔和欲以脈法解決疾病，若仲景則辨証為主，不專恃脈也。”

這是我們讀仲景書的基本要點，要之，前人的記載，只有是供給我們作參考的價值，決不能一成不變，死板板地相信它，甚至還要如法炮制，這是行不通的。要知道社會上的事事物物總是推移的，毛主席實踐論不是這樣的指示着我們嗎？“任何過程，不論是屬於自然界的與屬於社會的，由於內部的矛盾與鬥爭，都是向前推移，向前發展的，人們的認識運動也應跟着推移與發展。”

第十講 切脈在臨床上的合理應用

中醫的脈學，內容自然是很豐富的，但其中也不免混雜有很多不適用的東西，如果我們不加以研究、批判、整理，一成不變的把它接受下來，這不僅難于很好地應用於臨床，解決問題，對於發揚祖國醫學遺產來說，也可謂沒有盡到一定的責任。西醫因其物理診斷方法的日益昌明，檢查脈搏（切脈），早不居診斷中的重要地位，惟中醫于物理診斷的方法既沒有掌握，而于古代遺留下來這點古

老的“脈学”，复不加以研究整理，依旧鑿空虛談，不結合实际，这就不是研究科学的科学态度。

那末，究应如何合理的运用切脈來辨認疾病呢？茲分做以下三方面來說：

(一) 关于脈至數

健康成人的脈至數，每分鐘約自七十至七十五至，脈至數的計算，最好用時計表，不要憑自己（医生）的呼吸（理由見前），以時計表的秒針做根据，这是最精当的方法。

(1) 年齡关系，約如下表：

年齡	每分鐘脈搏數
初生兒	一三〇——一四〇
一歲	一二〇——一三〇
二歲	一〇五
三歲	一〇〇
四歲	九七
五歲	九四——九〇
十歲	九〇
十歲——十五歲	七六
十五歲——二〇歲	七〇
二〇歲——二五歲	七〇
二五歲——五〇歲	七〇
六〇歲	七四
八〇歲	七九

(2) 男女关系：女子的脈至數，要比同年的男子稍多。

(3) 時間关系：日中數增，入夜減少，日晡时达到当日的最多数，清早則降到最少数。

(4) 飲食关系：食后，尤其是飽食后，以及攝取了热燙飲食物后，在一二小时中脈搏便增加了，絕食时便減少。

(5) 运动关系：身体运动，必然引起脈至數的增加，偶有比常至數增加到一倍的，还有僅僅变动位置，而脈搏即受其影响的，平

臥時的脈至數最少，端坐起立，數略增，如重病恢復期的病人，僅使其在床上起坐，其脈至數便有著明的增進，因此，切脈以仰臥的位置行之最標準。

(6) 精神關係：精神的興奮，尋常都影響到脈至數的增加，神經過敏的人，其影響較健康人更為明顯。

(7) 氣溫關係：外界氣溫有大變化時，脈搏亦會受到它的影響，每每氣溫升，脈搏便增，氣溫降便減。

數脈 搏動頻數，每分鐘超過平常數，舊說的“疾”脈，也屬於這一類，常見于下列各病：

一、熱性諸病：由於高溫的刺激，脈搏隨而增加，每百至示中熱，百二十至以上示高熱，百六十至以上，便豫後不良。舊說以數脈為熱，便指此。

二、心臟病：如瓣膜異常及其炎症，尤以僧帽瓣膜異常等，最為常見。

三、熱性病的虛脫期：心臟衰弱或麻痺時，脈數而小，金匱上亦有“振寒脈數”，“身無熱，脈數”的記載。代償機能有障礙的心瓣膜病，以及因心筋疾病而心臟麻痺的，都見數脈，但都不是熱症。

四、迷走神經麻痺：因迷走神經能制止心臟的運動，一經麻痺，心臟的運動便無所制而加速，因此脈亦見數，如神經性的心悸亢進（怔忡之類），都脈來疾數。

五、一切疼痛性病及驚愕畏怖等，脈亦見數，如金匱的腸癰脈數，婦人繞臍寒疝，兩脅疼痛的脈數，皆是。

脈來頻數，而其橈骨動脈的搏動部有迫趨于手掌一端之勢（出于魚際），叫做促脈，于臨床上雖偶有見，而應用時不太多。

遲脈 脈搏遲緩，每分鐘不及平常數，甚至三十至以下，亦時或有之，常見于下列諸病：

一、脂肪心（主要見喘息，皮膚發紫，下肢腫），心筋炎（主要見心悸亢進，喘息，苦悶疼痛），常引起冠狀動脈硬變，因而脈遲。

二、大動脈口狹窄（主要見顏面蒼白、特發眩暈、卒倒、癲癇樣發作等），因流入動脈之血液減少，脈亦見遲。

三、大失血後，動脈血壓遽然減低，脈必現遲。

四、胃潰瘍，鉛中毒，疝痛等下腹臟器的疼痛性疾病。

五、神經衰弱症。

六、肝發性的黃疸病，由于胆酸混入血液，心臟神經節的作用因而微弱，故脈遲。

七、諸急性腎炎，因左心室的肥大，脈亦見遲。

八、腦出血、腦水腫、腦腫瘍等，因腦壓增加，迷走神經被刺激而興奮，脈都見遲。

九、急性熱病分利後，脈搏隨着熱低而減少。

以上遲脈，除六、七兩項外，與舊說遲為寒（衰減性）的理論，大致是通的。

（二）關於脈搏的調節

健康人的脈搏，均勻而整齊，張太素描寫健康脈的“緩”脈說：“應指和緩，往來甚勻。”所以舊說的緩脈，不應該認做病脈。一旦病了，脈搏便往往失調，而見着種種不整的脈搏，例如：

一、僧帽瓣口狹窄（主要見顏面蒼白，兩頰，鼻翼，口脣等處小靜脈怒張而發紫，心臟部隆起等症）脈搏細小頻數而不整。

二、心筋炎：脈搏細小弱頻數，每分鐘數達一百五十至而常不整。

三、各種心瓣膜異常以及重症心臟衰弱，脈搏都呈不整的搏動。

不整脈的具體表現，有如下列的脈搏：

缺止脈：心臟的縮張有時歇止。

間歇脈：心臟並不歇止，而其收縮力太弱，血液不能充分送入橈骨動脈。

以上兩種脈搏，統稱之曰“結代脈”。相當于舊說的“結”脈。

交換脈：脈波一大一小，交互搏動。

二連脈、三連脈、四連脈：每于二至或三至四至……之後，必有一至間歇不見，相當于舊說的“代脈”。習見于代償機能有障礙的心臟病。

不整脈	{	缺止脈	} 結代脈——相当于旧說的“結”脈
		間歇脈	
		交換脈	
		二連、三連、四連脈——相当于旧說的“代”脈	

(三) 关于脈性

所謂脈性，就是脈搏的性狀，这是全憑指端觸覺的一種技術，概括的分为下列六种：

大脈 凡動脈管寬廣，心臟機能強盛，以及左心室肥大時，必現大脈，旧說中因于心机亢盛，脈管充血的“洪”，淺層動脈擴張而充血的“浮”，血液充盈、血壓高漲的“實”，擴張神經興奮而脈管擴大、血液虛少的“芤”，都屬於大脈一類。

小脈 凡動脈管狹窄，心臟機能衰弱，以及動脈系內血量的減少，如高度貧血、僧帽瓣口狹窄時，則見小脈。旧說中因心力不強，血液不充的“細”，內部動脈充血，淺層動脈貧血的“沉”，心力衰弱，搏動不顯的“伏”，都屬於小脈一類。

兩手脈也有時大小各異的，在健康人，是因兩手脈管生理不同的原故。在病人，則因血塞、血栓、大動脈或無名動脈生動脈瘤，妨礙血行，以及一側的動脈，受到胸腔中腫瘍的壓迫等的原故。

硬脈（緊張脈） 左心室肥大，用強力輸送血液到脈管里去，以及動脈硬變的脈體便見硬固或緊張。硬脈是腎萎縮（主要見頑固頭痛，視力障礙，耳鳴多尿，喘息心悸等）兼心臟肥大者的特征，鉛中毒、癌痛、腦膜炎、腦卒中初期，亦可見到硬脈，由于血管神經遭受刺激而致。旧說中因收縮神經興奮而不充血的“弦”，淺層動脈充血而硬度較大的“緊”，動脈硬化的“革”和“牢”，都屬於硬脈一類。

軟脈 凡僧帽瓣狹窄，以及心臟機能衰弱，致動脈系中的血量減少，便見軟脈，其軟度于指下稍壓即不動。旧說中因于心力衰弱血壓低落的“濡”，心力衰弱而又血少的“弱”，心弱血少，而脈管失去彈力的“微”，“散”，脈管弛緩而血少的“虛”，都屬於軟脈一類。

疾脈 脈波疾起疾落，搏動頗短，于大動脈瓣閉鎖不全時最易

見，因血液从肥大的左心室，強力的射到动脈里，动脈因而強勁，迅速膨脹，血液一面向尋常徑路送往毛細血管，一面由于瓣膜閉鎖不全，逆流入左室，因此动脈于膨起后便又急行收縮，而現疾脈，其他是使动脈壁弛緩諸病如脚氣、水血症（因水分排洩不充分，因而致血液水分过多）热水浴后，都可以見到疾脈，旧說中因脈管縮張皆速，以及熱病而心力亢奮的“滑”、心力強而脈管的緊張力減弱的“勁”，都屬於疾脈一类。

徐脈 凡大动脈口狹窄和动脈硬變，都見徐脈，前者因血液徐徐流过狹窄的脈口，以至于大动脈，而动脈亦徐徐擴張，徐徐收縮的原故，后者則以动脈管彈力減少，于其擴張，多有反抗，而收縮亦迟徐，鉛中毒、疝痛、腹膜炎等，多見徐脈，旧說中因脈管硬化而乏彈力的“澀”，便屬於徐脈这一类。

了解了脈搏的至數、調節、性狀三事，并知道了古人多种脈性的所屬（長脈短脈是指脈動顯現部的修促，屬於生理，无所主病），便足夠臨床上的切实应用了。

参考引用書目

周禮註疏	賈公彥	醫學源流論	徐靈胎
史記	司馬遷	脈訣乳海	王邦傳
隋志	長孫无忌	醫宗金鑑	錢斗保等
王子安集	王勃	瀕湖脈學	李時珍
宋志	沈約	瘟疫論	吳又可
崇文總目	王堯臣	活人書	朱肱
蘇竹堂書目	叶盛	陳修園醫書	陳修國
朱文公集	朱熹	章太炎醫學道著	章太炎
吳草廬文集	吳草廬	人寸診補正	廖季平
素問王冰註	王冰	脈學輯要評	廖季平
靈樞經		三部篇補正	廖季平
靈樞經脈箋	呂復	皇漢醫學	湯本求真
難經集註	王九思等	生理學	蔡翹
註解傷寒論	成無己	脈辨	閻德潤
金匱玉函要略方論	王叔和	現代看護學	丁惠康
王氏脈經	王叔和	醫學革命論	余云岫
難經疏義	王叔和	診斷治療	陸淵雷
千金要方	孫思邈	傷寒今釋	陸淵雷
八十一難經註釋	楊玄操	金匱今釋	陸淵雷
景岳全書	張景岳	診斷學	湯爾和
診家正眼	李中梓	邱氏最新內科學	邱偉
本草衍義	寇宗奭	急慢性傳染病學	陳方之
診宗三昧	張路玉	生理解剖學	蘇醒
診家樞要	滑伯仁	診斷提綱	祝味菊
察脈真經	楊仁齋	仲景脈法學案	任應秋
脈訣刊誤	汪石山	(散見醫誌論文不錄)	
全生指迷方	王士亨		

参考引用書目

周禮註疏	賈公彥	醫學源流論	徐靈胎
史記	司馬遷	脈訣乳海	王邦傳
隋志	長孫无忌	醫宗金鑑	錢斗保等
王子安集	王勃	瀕湖脈學	李時珍
宋志	沈約	瘟疫論	吳又可
崇文總目	王堯臣	活人書	朱肱
蘇竹堂書目	叶盛	陳修園醫書	陳修國
朱文公集	朱熹	章太炎醫學道著	章太炎
吳草廬文集	吳草廬	人寸診補正	廖季平
素問王冰註	王冰	脈學輯要評	廖季平
靈樞經		三部篇補正	廖季平
靈樞經脈箋	呂復	皇漢醫學	湯本求真
難經集註	王九思等	生理學	蔡翹
註解傷寒論	成無己	脈辨	閻德潤
金匱玉函要略方論	王叔和	現代看護學	丁惠康
王氏脈經	王叔和	醫學革命論	余云岫
難經疏義	王叔和	診斷治療	陸淵雷
千金要方	孫思邈	傷寒今釋	陸淵雷
八十一難經註釋	楊玄操	金匱今釋	陸淵雷
景岳全書	張景岳	診斷學	湯爾和
診家正眼	李中梓	邱氏最新內科學	邱偉
本草衍義	寇宗奭	急慢性傳染病學	陳方之
診宗三昧	張路玉	生理解剖學	蘇醒
診家樞要	滑伯仁	診斷提綱	祝味菊
察脈真經	楊仁齋	仲景脈法學案	任應秋
脈訣刊誤	汪石山	(散見醫誌論文不錄)	
全生指迷方	王士亨		